



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Optimal

ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI BARU LAHIR

Siswi Wulandari, SST., Bd., M.Keb

Nirma Lidia Sari, S.ST, M.KM

Kadek Yuke Widyantari, S.SiT., M.Keb

Bdn.Selasih Putri Isnawati Hadi, S.Tr.Keb.,M.Tr.Keb

Baiq Dika Fatmasari, S.ST.,M.Keb

Ardiyanti Hidayah, SST., Bd., M. Kes



ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI BARU LAHIR

Siswi Wulandari, SST., Bd., M.Keb

Nirma Lidia Sari, S.ST, M.KM

Kadek Yuke Widyantari, S.SiT., M.Keb

Bdn.Selasih Putri Isnawati Hadi, S.Tr.Keb.,M.Tr.Keb

Baiq Dika Fatmasari, S.ST.,M.Keb

Ardiyanti Hidayah, SST., Bd., M. Kes



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI BARU LAHIR

Penulis:

Siswi Wulandari, SST., Bd., M.Keb
Nirma Lidia Sari, S.ST, M.KM
Kadek Yuke Widyantari, S.SiT., M.Keb
Bdn.Selasih Putri Isnawati Hadi, S.Tr.Keb.,M.Tr.Keb
Baiq Dika Fatmasari, S.ST.,M.Keb
Ardiyanti Hidayah, SST., Bd., M. Kes

Desain Cover:

Ivan Zumarano

Tata Letak:

Achmad Faisal

ISBN:

978-623-88659-1-8

Cetakan Pertama:

April, 2023

Hak Cipta 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F
Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah
Jakarta Barat

Website: www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: [@bimbel.optimal](https://www.instagram.com/bimbel.optimal)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dalam segala kesempatan. Alhamdulillah atas rahmat dan karunianya penulis telah menyelesaikan Buku Asuhan Kebidanan pada bayi Baru Lahir.

Buku ini membahas tentang asuhan kebidanan bayi baru lahir normal segera dan lanjutan, Inisiasi Menyusu Dini (IMD), Masalah pada Bayi baru lahir, Infeksi pada Neonatus dan pencegahannya, Imunisasi dan Asuhan kebidanan komplementer pada bayi baru lahir.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang bersifat membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam menyelesaikan buku ini. Terutama semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat.

Jakarta, Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 ASUHAN KEBIDANAN SEGERA DAN LANJUTAN PADA BAYI BARU LAHIR	1
A. Asuhan Bayi Baru Lahir Normal.....	2
B. Asuhan Bayi Baru Lahir Bermasalah.....	3
C. Persiapan penanganan BBL, Penilaian Awal dan Manajemen Segera	3
D. Penilaian Manajemen Lanjut	5
E. Perawatan Lanjut	5
F. Dukungan Emosional, Komunikasi, dan Kunjungan	6
G. Catatan Medik.....	6
H. Pemulangan dan Tindak Lanjut.....	7
I. Rangkuman Materi.....	7
DAFTAR PUSTAKA	9
BAB 2 INISIASI MENYUSU DINI (IMD)	11
A. Deskripsi	12
B. Uraian Materi.....	13
C. Pertanyaan dan Jawaban Seputar IMD	19
DAFTAR PUSTAKA	21
BAB 3 ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI BARU LAHIR DENGAN MASALAH	23
A. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	24
B. Hipotermi.....	26
C. Ikterus Neonatorum	27
D. Hipoglikemia	29
E. Gangguan Nafas	30
DAFTAR PUSTAKA	32
BAB 4 IMUNISASI	37
A. Definisi Imunisasi.....	38
B. Tujuan Pemberian Imuniasi	39
C. Macam-Macam Imunisasi.....	39
D. Jenis Imunisasi Dasar	40
E. Jenis Imunisasi Rekomendasi IDAI Tahun 2020	43
DAFTAR PUSTAKA	44
BAB 5 INFEKSI PADA NEONATUS DAN PENCEGAHANNYA	47
A. Deskripsi	48
B. Uraian Materi.....	48
DAFTAR PUSTAKA	55
BAB 6 ASUHAN KEBIDANAN KOMPLEMENTER PADA BAYI BARU LAHIR	57
A. Konsep Dasar Asuhan Kebidanan Komplementer.....	58
B. Asuhan Komplementer Pada Bayi dan Balita.....	59
C. Jenis Asuhan Kebidanan Komplementer Pada Bayi Baru Lahir.....	60
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB 1

ASUHAN KEBIDANAN SEGERA DAN LANJUTAN

PADA BAYI BARU LAHIR

Siswi Wulandari, SST., Bd., M.Keb



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

BAB 1

ASUHAN KEBIDANAN SEGERA DAN LANJUTAN PADA BAYI BARU LAHIR

Siswi Wulandari, SST., Bd., M.Keb

A. Asuhan Bayi Baru Lahir Normal

Asuhan Kebidanan segera pada bayi baru lahir normal adalah asuhan kebidanan yang diberikan pada bayi selama jam pertama setelah kelahiran (Sarwono Prawihardjo, 2010). Aspek terpenting dari asuhan segera setelah lahir adalah:

1. Menjaga agar bayi tetap hangat dan terjadi kontak antara kulit bayi dengan kulit ibu.

Mekanisme pengaturan suhu pada bayi belum berfungsi dengan baik sehingga beresiko mengalami hipotermi. Hipotermi mengakibatkan hipoglikemi dan bahkan kematian. Mekanisme kehilangan panas melalui cara sebagai berikut:

- a. Evaporasi, kehilangan panas pada bayi karna tidak segera dikeringkan
- b. Konduksi, kehilangan panas melalui kontak langsung antara bayi dan ibu
- c. Konveksi, kehilangan panas pada bayi bila ditempatkan di suhu ruangan dibawah 25⁰ C
- d. Radiasi, kehilangan panas jika bayi ditempatkan dekat kipas angin atau dekat jendela terbuka

Berikut langkah-langkah dalam menjaga bayi tetap hangat:

- a. Memastikan bayi tetap hangat dan terjadi kontak antara kulit bayi dengan kulit ibu.
 - b. Mengganti haduk/kain yang basah, dan bungkus bayi tersebut dengan selimut dan memastikan bahwa kepala telah terlindung dengan baik untuk mencegah keluarnya panas tubuh.
 - c. Memastikan bayi tetap hangat dengan memeriksa telapak bayi setiap 15 menit.
 - d. Apabila telapak bayi terasa dingin, memeriksa suhu aksila bayi.
 - e. Apabila suhu bayi kurang dari 36.5⁰ C, segera menghangatkan bayi.
2. Mengusahakan adanya kontak antara kulit bayi dengan kulit ibunya sesegera mungkin.
 - a. Memberikan bayi kepada ibunya secepat mungkin. Kontak dini antara ibu dan bayi penting untuk kehangatan mempertahankan panas yang benar pada bayi baru lahir dan ikatan batin dan pemberian ASI.
 - b. Mendorong ibu untuk menyusui bayinya apabila bayi tetap siap dengan menunjukkan rooting reflek. Jangan paksaan bayi untuk menyusu.
 - c. Tidak memisahkan bayi sedikitnya satu jam setelah persalinan.

3. Menjaga pernafasan bayi
 - a. Memeriksa pernafasan dan warna kulit setiap 5 menit.
 - b. Jika tidak bernafas, lakukan hal sebagai berikut: keringkan bayi dengan selimut atau handuk hangat, gosoklah punggung bayi dengan lembut.
 - c. Jika belum bernafas setelah 1 menit mulai resusitasi.
 - d. Bila bayi sianosis/kulit biru, atau sukar bernafas/frekuensi pernafasan $30 > 60$ kali/menit, berikan oksigen dengan kateter nasal.
4. Merawat mata bayi
 - a. Memberikan Eritromicin 0,5% atau Tetrasiklin 1% untuk pencegahan penyakit mata krl klamidia, atau
 - b. Memberikan tetes mata perak nitrat atau Neosporin segera setelah lahir.

B. Asuhan Bayi Baru Lahir Bermasalah

Bayi yang memerlukan perawatan adalah berasal dari rumah, dirujuk dari rumah sakit lain atau dari ruang perawatan lain di rumah sakit yang sama maupun sakit dari kamar bersalin karena terjadi komplikasi persalinan. Penatalaksanaan kasus-kasus tersebut memerlukan perencanaan, implementasi dan evaluasi perawatan berdasarkan penilaian lanjut terhadap kondisi bayi. Perawatan bayi di fasilitas pelayanan kesehatan dibagi dalam beberapa langkah seperti yang diterangkan di bawah ini:

Ikuti prinsip dan praktek pencegahan infeksi setiap memeriksa dan mengobati bayi

C. Persiapan penanganan BBL, Penilaian Awal dan Manajemen Segera

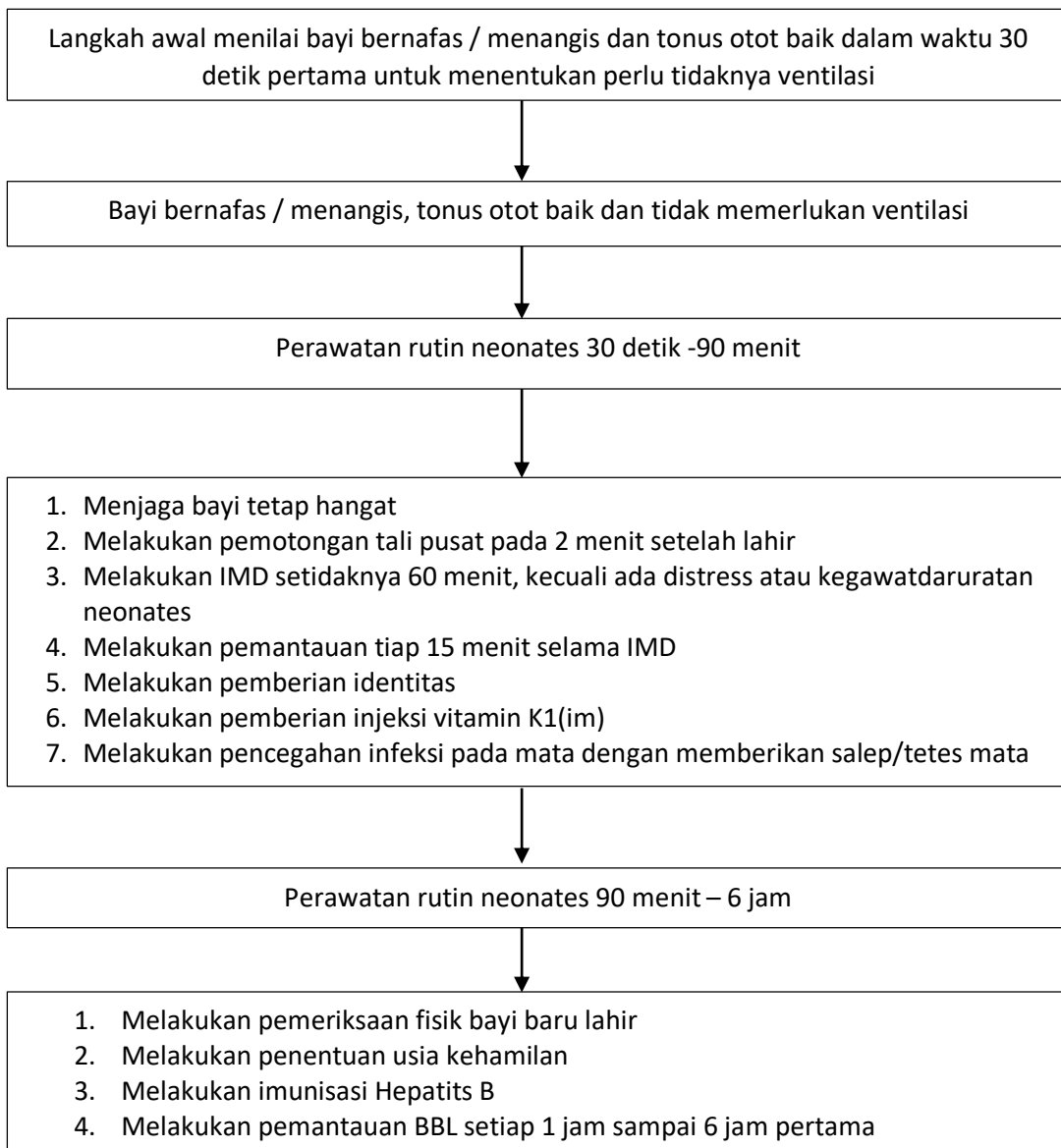
Persiapan penanganan BBL, meliputi:

- a. Persiapan diri
Penolong persalinan dalam kondisi bersih dan terlindungi dengan melakukan cuci tangan dan penggunaan APD
- b. Persiapan alat
Peralatan dan bahan yang akan digunakan dalam menolong persalinan dalam kondisi siap pakai, bersih dan lengkap
- c. Persiapan tempat
Ruang yang digunakan ruang yang hangat dan terang. Tempat resusitasi bersih, kering, hangat, datar, rata dan cukup keras. Menyalakan infarm warmer 20 menit sebelum persalinan, jika tidak ada infarm warmer maka gunakan meja resusitasi dengan lampu pijar 60 watt yang berjarak 60 cm dari bayi.
- d. Persiapan keluarga

Memberikan dukungan kepada ibu dan keluarga selama proses persalinan dengan memberikan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) meliputi: persiapan laktasi sehari-hari dan mengenalkan tanda bahaya pada ibu dan bayi

Penilaian Awal dan manajemen segera

Penilaian awal ini bertujuan untuk memastikan apakah bayi memerlukan entilasi atau tidak. Langkah penilaian awal BBL adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Langkah penilaian BBL

Berikut langkah pada bayi umur kurang dari 7 bulan:

1. Begitu seorang bayi umur kurang 7 hari datang di fasilitas kesehatan, harus segera ditangani, jangan dibiarkan menunggu.
2. Lakukan prosedur administrasi penerimaan pasien secepat mungkin agar bayi dapat segera diperiksa.
3. Lakukan perawatan pada bayi sakit atau bayi kecil sebelum urusan administrasi penerimaan selesai.
4. Sewaktu tiba, bayi segera dinilai untuk melihat adanya tanda kegawatan yang menunjukkan bayi berada dalam keadaan kritis dengan resiko kematian dalam beberapa menit.
 - a. Symbol menerima tanda kegawatan, perkenalkan diri kepada ibu atau yang mengantar bayi dan tanyakan:
 - 1) Kapan mulai timbul
 - 2) Nama ibu dan bayi
 - 3) Umur ibu dan bayi
 - 4) Asal rujukan dan surat rujukan
 - b. Bila memungkinkan biarkan ibu bersama bayinya pada saat dilakukan pemeriksaan atau tindakan. Berikan pertolongan sesegera terhadap gejala kegawatan seperti tertera pada tabel A-1 sebelum melakukan penilaian lanjut.

Prioritaskan melakukan stabilisasi bayi sakit atau bayi kecil sebelum menilai dan mengobati penyebab masalah

D. Penilaian Manajemen Lanjut

1. Bila keadaan bayi sudah stabil, lengkapi pemeriksaan menentukan masalah, dan bila perlu bayi dirawat.
2. Bila diperlukan lakukan manajeme spesifik terhadap masalah yang telah diidentifikasi, untuk menentukan bab apa yang akan digunakan.
3. Bila perlu melakukan persiapan memindahkan dan merujuk.

E. Perawatan Lanjut

Disamping perawatan khusus untuk masalah bayi, berikan perawatan umum dan perawatan lanjut.

1. Buat perencanaan asuhan kebidanan yang meliputi kebutuhan bayi.
2. Pantau kemajuan-kemajuan bayi dengan melakukan penilaian umum terus menerus tanpa terlalu mengganggu bayi termasuk:
 - a. Frekuensi nafas
 - b. Denyut jantung

- c. Warna kulit
 - d. Suhu tubuh
 - e. Kecepatan dan volume cairan IV;
 - f. Frekuensi dan volume pemberian minum
3. Siap dengan perubahan perencanaan perawatan bila terjadi perubahan kondisi bayi yang ditentukan oleh hasil pemantauan khusus dan minum.
 4. Bila perlu siapkan transportasi dan atau rujukan.

F. Dukungan Emosional, Komunikasi, dan Kunjungan

Dukungan keluarga pasca melahirkan sangat penting untuk ibu postpartum (Baggett et al., 2021).

1. Berikan dukungan emosional kepada ibu dan anggota keluarga lainnya.
2. Anjurkan ibu untuk tetap bersama bayi. Bila ini tidak memungkinkan, biarkan ia berkunjung setiap saat dan siapkan kamar untuk menyusui.
3. Ijinkan dan anjurkan kunjungan oleh keluarga atau teman dekat apabila memungkinkan.
 - a. Apabila jumlah pengunjung harus dibatasi, pilih seorang sebagai wakil yang dapat melaporkan kepada yang lainnya.
 - b. Anjurkan keluarga untuk berkunjung tetapi jangan dipaksa. Anggota keluarga mungkin segan mengunjungi bayi karena takut melihat keadaannya atau tidak mau terlalu dekat kepada bayi sebelum mengetahui kemungkinan bayi akan hidup;
 - c. Jangan menghubungkan jumlah kunjungan dengan kepedulian terhadap bayi. Keadaan seperti biasa transport, keperluan untuk merawat anak lain di rumah, keperluan ibu berobat ke rumah sakit lain, atau tanggungjawab pekerjaan, dapat menghambat kunjungan ibu atau keluarga.
4. Ijinkan kakak bayi menjenguk adiknya kecuali kakak tersebut menderita demam, tanda sakit akut atau terpapar penyakit menular (misal cacar air). Pastikan kakak yang berkunjung.
 - a. Hanya kontak dengan adiknya sendiri
 - b. Telah mencuci tangan
 - c. Diawasi setiap saat

G. Catatan Medik

Pencatatan medik bertujuan untuk mendokumentasikan asuhan kebidanan yang telah diberikan.

1. Catat semua perubahan dan rencana asuhan kebidanan dengan jelas dan sampaikan kepada semua petugas yang terlibat.
2. Bila berada di Rumah Sakit, Catat semua perubahan kondisi bayi dan mengkomunikasikan kepada staf yang lain. Pastikan agar informasi ini

disampaikan kepada petugas pengganti waktu pergantian juga kepada dokter jaga.

H. Pemulangan dan Tindak Lanjut

Setelah ibu dan bayi mendapat asuhan kebidanan, maka tiba saatnya ibu dan bayi di pulangkan dengan memberikan informasi yang dibutuhkan, sebagai berikut:

1. Pulangkan bayi jika sudah baik, tergantung pada respon terhadap pengobatan.
2. Rencanakan pemulangan dengan:
 - a. Memberikan imunisasi sesuai jadwal
 - b. Memberikan petunjuk cara perawatan di rumah
 - c. Memberikan konseling tentang menyusui dan pastikan bahwa bayi menyusui dengan benar.
3. Pulangkan bayi.
4. Bila perlu diberi jadwal untuk kunjungan tindak lanjut berikutnya, karena adanya kondisi khusus dan untuk memantau pemberian minum dan pertumbuhan.

I. Rangkuman Materi

1. Asuhan Segera Bayi Baru Lahir adalah Asuhan yang diberikan pada bayi selama 1 jam pertama setelah kelahiran.
2. Aspek penting Asuhan Bayi Baru Lahir:
 - a. Menjaga agar bayi tetap hangat dan terjadi kontak kulit bayi dan kulit ibu.
 - b. Mengusahakan adanya kontak kulit bayi dan ibu sesegera mungkin.
 - c. Menjaga pernafasan.
 - d. Perawatan mata.
3. Perawatan bayi baru lahir bermasalah adalah perawatan dari rumah atau dari rumah sakit lain yang terjadi komplikasi persalinan.
4. Penatalaksanaan kasus-kasus tersebut memerlukan perencanaan, implementasi dan evaluasi perawatan berdasarkan penilaian lanjut terhadap kondisi bayi.
5. Penerimaan, penilaian cepat dan manajemen segera:
 - a. Bayi < 7 hari datang di fasilitas kesehatan, harus segera ditangani.
 - b. Lakukan prosedur penerimaan pasien secepat mungkin agar bayi segera diperiksa.
 - c. Lakukan perawatan bayi sakit atau bayi kecil sebelum urusan administrasi penerimaan selesai.
 - d. Bayi segera dinilai adanya tanda kegawatan yang menunjukkan bayi dalam keadaan kritis dengan risiko kematian.
6. Perawatan lanjut
 - a. Buat perencanaan asuhan kebidanan yang meliputi kebutuhan bayi.

- b. Pantau keadaan umum bayi terus menerus.
 - c. Siap dengan perubahan perencanaan perawatan bila terjadi perubahan kondisi bayi.
 - d. Bila perlu siapkan transportasi dan atau rujukan.
7. Dukungan emosional
- a. Beri dukungan emosional kepada ibu dan anggota keluarga
 - b. Anjurkan ibu untuk tetap bersama ibunya
 - c. Ijinkan dan anjurkan kunjungan keluarga
 - d. Ijinkan kakak bayi menjenguk adiknya.
8. Catatan medik
- a. Catat rencana perawatan dan petugas
 - b. Catat semua perubahan kondisi bayi
 - c. Pastikan informasi tentang petugas dan dokter jaga.
9. Pemulangan tindak lanjut
- a. Pulangkan bayi bila sudah baik
 - b. Rencana pemulangan
 - c. Pulangkan
 - d. Jadwal kunjungan ulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Baggett, K. M., Davis, B., Sheeber, L., Miller, K., Leve, C., Mosley, E. A., Landry, S. H., & Feil, E. G. (2021). Optimizing social-emotional-communication development in infants of mothers with depression: Protocol for a randomized controlled trial of a mobile intervention targeting depression and responsive parenting. *JMIR Research Protocols*, 10(8). <https://doi.org/10.2196/31072>
- Carlo, W. A., Polin, R. A., Papile, L. A., Tan, R., Kumar, P., Benitz, W., Eichenwald, E., Cummings, J., & Baley, J. (2014). Respiratory Support in Preterm Infants at Birth. *Pediatrics*, 133(1), 171–174. <https://doi.org/10.1542/PEDS.2013-3442>
- Choirunisa, S., Adisasmita, A., Izati, Y. N., Pratomo, H., & Iriani, D. (2021). Kangaroo mother care practices for low birthweight newborns in a district hospital in Indonesia. *Child Health Nursing Research*, 27(4), 354. <https://doi.org/10.4094/CHNR.2021.27.4.354>
- Hidayat Alimul Aziz. (2008). *Pengantar Ilmu Kesehatan Anak Untuk Pendidikan Kebidanan* (Angriani Rida (Ed.)).
- Hypothermia in Neonates - Pediatrics - MSD Manual Professional Edition*. (n.d.).
- Kebidanan, T. (2017). *MODUL ASUHAN NEONATUS, BAYI, BALITA, DAN ANAK PRA SEKOLAH*. POLTEKKES KEMENKES MEDAN.
- Kemenkes. (2012). *Pedoman pengendalian infeksi saluran pernafasan akut*. Kemenkes RI.
- Kramer, L. I. (1969). Advancement of dermal icterus in the jaundiced newborn. *American Journal of Diseases of Children* (1960), 118(3), 454–458. <https://doi.org/10.1001/ARCHPEDI.1969.02100040456007>
- Lisfasiska, N. M., & Asiyah, S. (2017). Perbedaan Kejadian Perdarahan Dan Infeksi Tali Pusat Yang Diikat Dengan Benang Dan Umbilical Cord Clamp. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 2(1), 61. <https://doi.org/10.32831/jik.v2i1.30>
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 450 / MENKES / SK / IV /2004 tentang Pemberian ASI Secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia, (2004).
- UU Republik Indonesia no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (2009).
- PP Republik Indonesia No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, (2012).
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 15 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehata, (2014).
- Mitayani. (2011). *Asuhan Keperawatan Maternitas*. Salemba Medika.

- Nasution Yusnita Eva. (2022). *Monograf Penulisan Imunisasi Dasar Lengkap* (Nasution Bincar (Ed.)). PT. Inovasi Pertama Internasional.
- Negrato, C. A., & Gomes, M. B. (2013). Low birth weight: Causes and consequences. *Diabetology and Metabolic Syndrome*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/1758-5996-5-49/METRICS>
- Nyandiko, W. M. (2013). Newborn Thermoregulation. *Champlain Maternal Newborn Regional Program (CMNRP)*, June, 1–16.
- Rahmawati Dewi Septi dkk. (2019). *Pedoman Praktis Imunisasi pada Anak* (Tim UB press (Ed.); Cetakan I). UB Press.
- Reuter, S., Moser, C., & Baack, M. (2014). Respiratory Distress in the Newborn. *Pediatrics in Review*, 35(10), 417. <https://doi.org/10.1542/PIR.35-10-417>
- Roesli, U. (2012). *Inisiasi Menyusu Dini Plus ASI Eksklusif*. Pustaka Bunda (Group Puspa Swara).
- Sakonidou, S., & Dhaliwal, J. (2015). The management of neonatal respiratory distress syndrome in preterm infants (European Consensus Guidelines—2013 update). *Archives of Disease in Childhood - Education and Practice*, 100(5), 257–259. <https://doi.org/10.1136/ARCHDISCHILD-2014-306642>
- Sari Indria Lia. (2020). *Buku Ajar Imunisasi Bayi*. Media Sains Indonesia.
- Sarwono Prawihardjo. (2010). Ilmu Kebidanan Edisi IV. In *Kesehatan Reproduksi*.
- Sembiring, J. B. (2019). *Buku Ajar Neonatus, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah*. Deepublish Publisher.
- Wulandari Sri R.Made, dkk. (2021). *Modul Postnatal Education Package* (Wulandari (Ed.); Cetakan I). CV.Literasi Nusantara Abadi.

BAB 2

INISIASI MENYUSU DINI (IMD)

Nirma Lidia Sari, S.ST, M.KM



BAB 2

INISIASI MENYUSU DINI (IMD)

Nirma Lidia Sari, S.ST, M.KM

A. Deskripsi

Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017, Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah 15 per 1000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) adalah 24 per 1000 kelahiran hidup. Penyebab kematian neonatal adalah penyakit infeksi (36%), prematuritas (28%) dan asfiksia (23%). Penyakit infeksi adalah penyebab kematian paling umum pada bayi baru lahir. Infeksi dapat dicegah dengan meningkatkan imunoglobulin pada bayi baru lahir yang bayi dapatkan dari Air Susu Ibu (ASI), terutama kolostrum. Nutrisi yang terkandung dalam kolostrum sangat lengkap, termasuk antibodi yang berperan penting dalam mencegah penyakit, tumbuh kembang pada bayi.

Pada tahun 2009, WHO merekomendasikan pengenalan ASI sejak dini/Inisiasi Menyusu Dini (IMD), pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) sejak usia 6 bulan, dan pemberian ASI hingga bayi Prinsip pemberian nutrisi yang baik untuk anak menyatakan menyusui hingga 2 tahun. IMD merupakan salah satu penentu keberhasilan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Pernyataan ini didukung oleh beberapa penelitian yang menunjukkan adanya hubungan positif antara IMD dengan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan.

Adapun Syarat IMD dapat dilakukan atau tidak adalah, ibu dan bayi harus dalam keadaan sehat. Beberapa manfaat dilakukan IMD, diantaranya adalah dapat menekan angka kematian ibu dan bayi (AKI dan AKB), menunjang keberhasilan pemberian ASI eksklusif 6 bulan dan menguatkan ikatan batin antara ibu dan bayinya.

Aspek Hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif di Indonesia antara lain :

1. UU Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (2009) tentang Kesehatan pasal 128 ayat 1 (Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.
2. PP Republik Indonesia No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (2012)
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 450 / MENKES / SK / IV /2004 Tentang Pemberian ASI Secara Eksklusif Pada Bayi Di Indonesia, (2004)
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 15 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara

B. Uraian Materi

1. Pengertian Inisiasi Menyusu Dini

Inisiasi Menyusu Dini adalah proses menyusui yang dimulai sedini mungkin dengan cara menggendong bayi bersentuhan dengan kulit ibu selama satu jam pertama setelah lahir atau sampai proses menyusui pertama selesai. Cara bayi melakukan IMD ini disebut *the breast crawl*, atau merangkak mencari payudara (Roesli, 2012).

2. Manfaat Inisiasi Menyusu Dini

Beberapa manfaat dari tindakan IMD antara lain:

a. Mencegah hipotermia

Inisiasi Menyusu Dini bermanfaat mencegah anemia karena bayi mendapat kehangatan dari ibu melalui kontak kulit antara ibu dan bayi.

Sari (2020) mengobservasi mengamati langsung subjek manusia dan menyimpulkan bahwa setelah inisiasi menyusui dini, rata-rata suhu tubuh bayi baru lahir meningkat dengan interval 1–3 °C. Menyusui dini harus dimulai segera setelah lahir tanpa penundaan karena berat atau ukuran bayi.

Bayi bahkan tidak boleh membersihkan, tetapi cukup mengeringkan tangan mereka. Proses ini harus dilakukan secara skin-to-skin antara bayi dan ibu. Kulit ibu bersalin berfungsi sebagai inkubator, karena lebih hangat dari pada kulit ibu yang tidak bersalin. Secara otomatis dapat mempengaruhi suhu bayi baru lahir yang rentan mengalami kehilangan panas.

b. Salah satu poin keberhasilan pemberian ASI secara eksklusif

Bayi dapat memiliki kemampuan menyusui yang efektif dan lebih cepat, sehingga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk sukses menyusui. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa IMD merupakan salah satu kunci keberhasilan pemberian ASI eksklusif.

Penelitian Murti & Hendriani (2017) di Rumah Sakit Khusus Bersalin Balikpapan menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara inisiasi menyusui dini (IMD) dengan laktasi pada ibu post partum normal dimana Hasil χ^2 hitung = 6,806 > χ^2 tabel 3,841 didapatkan nilai signifikan = 0,009 < α 0,05, nilai OR diperoleh hasil = 13,000, artinya ibu post partum yang IMD punya peluang 13 kali untuk ASI lancar. Untuk itu, suami, keluarga dan petugas kesehatan dapat memulai pemberian ASI dini selama 1 jam segera setelah bayi lahir agar produksi ASI/laktasi tetap lancar. Hal ini tentu saja bermanfaat bagi ibu dan bayi.

c. Mengurangi Angka Kematian Bayi (AKB)

Anak-anak di bawah usia 5 tahun memiliki risiko kematian yang lebih rendah karena bayi lebih kecil kemungkinannya terkena infeksi. IMD memberikan bayi untuk mendapatkan kolostrum lebih cepat di awal kelahiran. Kolostrum mengandung antibodi yang sangat membantu mencegah infeksi, dan koloni flora baik yang bersentuhan dengan kulit dan dapat mencegah infeksi.

Edmond dkk (2006) dalam Fikawati et al (2015) melakukan penelitian terhadap ± 11.000 bayi di Ghana dan menyimpulkan bahwa 22% bayi hidup kurang dari 28 hari sebelum kelahiran dapat diselamatkan. Menunda menyusui pertama kali saat bayi berusia lebih dari 2 jam tetapi kurang dari 24 jam pertama hanya menyelamatkan 16% nyawa bayi di bawah 28 hari. Penundaan lebih lanjut dalam pelaksanaan IMD secara signifikan meningkatkan risiko kematian bayi.

d. Meningkatkan ikatan batin antara ibu dengan bayi

Pada proses IMD bayi segera setelah lahir diletakkan di dada ibu sehingga terjadi skin to skin contact, saat itu ibu dapat melihat langsung bayinya yang merangkak menuju payudara ibu. Kontak kulit ke kulit ibu dan bayi pada jam pertama setelah lahir dapat membuat ikatan antara ibu dan bayi dan mencegah terjadinya gagal tumbuh (growth faltering) pada bayi. Saat proses IMD ibu akan merasa rileks melihat bayinya yang baru lahir menyusu kepadanya. Tubuh ibu kemudian akan memproduksi hormon oksitosin yang berperan pada let down reflex ibu.

e. Mentransfer bakteri baik yang ada di permukaan kulit ibu ke bayi

Melalui kontak kulit ke kulit/skin to skin contact, bayi akan menjilat kulit ibu dan menelan bakteri yang menempel di kulit ibu. Menurut Hanson (2004) dalam Fikawati et al (2015) bakteri yang berkolonisasi di usus bayi bersaing dengan bakteri berbahaya dari lingkungan sehingga daya tahan tubuh bayi menjadi lebih optimal.

f. Meningkatkan kontraksi uterus

Ketika bayi menghisap puting ibu, hal itu merangsang pelepasan hormon oksitosin yang menyebabkan rahim berkontraksi, memfasilitasi pengeluaran plasenta, mengurangi risiko perdarahan pascapersalinan, dan mencegah anemia.

Penelitian yang dilakukan Putri et al., (2020), pada ibu-ibu postpartum Pada 16 kasus dan 16 kontrol, ibu nifas yang menjalani IMD ditemukan rata-rata tinggi fundus 3,13 cm di bawah pusat pada 2 jam, mencapai rata-rata 2,13 cm di bawah pusat pada 12 jam. Kelompok non-IMD juga mencapai hasil yang sama pada 2 dan 12 jam, rata-rata 1,63 cm di bawah tengah. Analisis bivariat menghasilkan p-value 0,000 dan p-value 0,030 setelah 2 jam

IMD pada kedua kelompok. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara inisiasi menyusui dini dengan pencapaian retraksi uteri pada ibu nifas.

g. Mencegah terjadinya hipoglikemia dan membantu pengaturan parameter biokimia lainnya pada beberapa jam pertama setelah lahir.

ASI mengandung zat gizi yang dibutuhkan bayi. Konsumsi ASI pada beberapa jam setelah lahir dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi dan mencegah bayi dari hipoglikemia.

3. Breast Crawl

Breast crawl adalah kemampuan bayi merangkak untuk menemukan payudara ibunya dan menentukan kapan pertama kali menyusui di payudara ibu. Saat bayi dibaringkan di dada ibu, pertama-tama terjadi proses menghisap dengan menarik puting susu ibu selama 35-50 menit. Bayi dapat menemukan puting susu ibunya dengan bantuan indra penciuman, penglihatan, dan perasa, serta suara dan sentuhan juga membantu dalam proses ini.

a. Indra Penciuman

Selain memproduksi ASI dan kolostrum, kelenjar susu pada payudara ibu juga mengeluarkan bau khas yang menarik bayi ke payudara ibu. Cairan amnion akan mengeluarkan bau khas pada tubuh bayi. Untuk itu, disarankan untuk mengeringkan tubuh bayi daripada membersihkannya.

b. Indra Penglihatan

Ketika bayi yang baru lahir terlihat dibatasi. Tapi bayi lebih tertarik pada warna hitam dan putih daripada abu-abu. Puting dan areola payudara ibu berwarna lebih gelap dibandingkan bagian payudara lainnya dan menarik perhatian bayi, sehingga bayi tertarik untuk meraih puting ibu. Hal ini yang membuat bayi semakin mendekat ke payudara ibu.

c. Indra Perasa

Bayi menghisap tangannya sendiri yang masih menempel pada air ketuban (jangan mengelap tangan bayi saat IMD, karena air ketuban berbau di tangan). Bayi mengasosiasikan aroma dengan aroma yang sama dari puting ibu mereka. Upaya ini akan membawa bayi lebih dekat ke dada ibu.

d. Indra Pendengaran

Bukti ilmiah menunjukkan bahwa janin dan bayi merespons suara dengan memperlambat detak jantungnya. Suara ibu dianggap sebagai sinyal yang mengukur lingkungan cairan ketuban. Sehingga bayi menghisap lebih lama saat mendengar suara ibunya. Detak jantung ibu juga bisa membantu menenangkan bayi. Oleh karena itu, disarankan ibu memberikan rangsangan suara dengan kata-kata yang baik selama IMD. Stimulasi pendengaran segera oleh ibu mungkin memiliki efek positif pada perkembangan sistem pendengaran bayi selanjutnya dan perkembangan sosial dan emosional.

4. Tahapan dalam Melakukan IMD

IMD dilakukan dengan meletakkan bayi telungkup di atas dada/perut ibu agar kulit bayi menempel dengan kulit ibu. IMD meningkatkan kemampuan dan kemauan ibu untuk terus menyusui selama masa bayi, memberi bayi kesempatan untuk memberi makan bayinya dengan kolostrum yang kaya akan antibodi, dan menurunkan suhu tubuh bayi dengan memberikan panas langsung ke tubuh bayi sehingga dapat mengurangi insiden kematian bayi akibat hipotermi.

Berikut merupakan tata cara pelaksanaan IMD yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan RI 2010 dalam Fikawati et al (2015) yaitu:

- a. Selepas bersalin, bayi lap seperlunya supaya kering (bukan dibersihkan), kecuali tangan.
- b. Pindahkan posisi bayi ke posisi terngkurap di dada atau perut ibu, dan kulit bayi menempel lekat pada kulit ibu.
- c. Biarkan bayi mencari puting payudara ibu dengan usahanya sendiri.

Tahap 1:

Setelah persalinan, lakukan penilaian pada bayi baru lahir dan keringkan bayi:

- 1) Ketika bayi lahir catat waktu kelahiran.
- 2) Letakkan bayi di perut bagian bawah ibu sambil menilai apakah bayi perlu dilakukan resusitasi atau tidak.
- 3) Bila bayi stabil dan tidak memerlukan resusitasi, keringkan badan bayi mulai dari bagian atas tubuh (wajah, kepala dan bagian tubuh lainnya) dengan lembut tanpa menghilangkan verniks yang menempel di tubuh bayi karena verniks bermanfaat membantu menyamankan dan menghangatkan tubuh bayi. Sesudah dikeringkan, tubuh bayi diselimuti untuk menunggu 2 menit sebelum tali pusat di-klem.
- 4) Jangan mengeringkan punggung tangan bayi. Aroma cairan amnion pada tangan bayi akan membantu bayi mencari puting ibunya yang memiliki bau sama.
- 5) Cek uterus untuk memastikan bahwa tidak ada lagi bayi dalam uterus (hamil tunggal) kemudian lakukan suntikkan oksitosin 10 UI secara intra muscular pada ibu.

Tahap 2:

Lakukan kontak kulit ibu dengan kulit bayi minimal satu jam

- 1) Sesudah tali pusat dipotong lalu diikat, posisikan bayi tengkurap pada dada ibu. Luruskan bahu bayi sampai bayi menempel pada dada ibu. Letakkan kepala bayi di antara payudara ibu namun tidak lebih tinggi dari puting.

- 2) Tutup dengan kain / selimut hangat tubuh ibu dan bayi dan pasang topi bayi di kepala bayi untuk menghindari penguapan pada bagian kepala
- 3) Kontak kulit bayi di dada ibunya paling sedikit dilakukan selama satu jam. Sarankan ibu untuk memeluk dan membelai bayinya. Bila perlu, letakkan bantal di bawah kepala ibu untuk memudahkan kontak visual ibu dan bayi dan jangan membersihkan payudara Ibu.
- 4) Setelah itu lanjutkan melakukan manajemen aktif, yaitu pengeluaran aktif plasenta yang berfungsi untuk membantu mencegah terjadinya perdarahan pasca persalinan.

Tahap 3:

Beri kesempatan pada bayi mencari dan menemukan puting susu ibu dan mulai menyusu

- 1) Biarkan bayi berusaha mencari, menemukan puting lalu menyusu sendiri.
- 2) Sarankan ibu dan orang lain agar tidak menginterupsi proses menyusu seperti memindahkan bayi dari satu payudara ke payudara lain. Biarkan bayi menyusu dari satu payudara saja. Biasanya bayi akan berhasil menemukan puting ibu pada 30-60 menit dan biarkan kontak kulit ibu dan bayi selama minimal 1 jam walaupun bayi telah menemukan puting kurang dari 1 jam pertama.
- 3) Tunda semua asuhan bayi baru lahir normal lainnya sampai setidaknya 1 jam atau lebih apabila bayi baru menemukan Puting setelah 1 jam.
- 4) Jika bayi harus dipindah keluar dari kamar bersalin sebelum 1 jam pertama atau sebelum bayi menyusu, upayakan ibu dan bayi dipindah bersama dengan tetap menjaga kontak kulit ibu dengan bayinya.
- 5) Apabila bayi belum dapat menemukan puting ibu dalam 1 jam, letakkan bayi pada posisi lebih dekat dengan puting susu ibu (secara lateral) dan biarkan terjadi kontak kulit ibu dan bayi selama 30-60 menit.
- 6) Bila bayi masih juga belum berhasil melakukan IMD dalam waktu 2 jam, pindahkan ibu ke ruang pemulihan bersama bayinya di atas dada ibu. Lakukan asuhan perawatan neonatal esensial lainnya seperti menimbang, pemberian vitamin K1, dan salep mata. Kemudian bayi dikembalikan kepada ibu untuk disusui.
- 7) Gunakan pakaian untuk bayi atau bayi diselimuti untuk menjaga kehangatan dan mencegah hipotermi. Kepala bayi ditutupi dengan topi selama beberapa hari pertama. Jika kaki bayi terasa dingin saat disentuh, pakaiannya dibuka lalu bayi ditelungkupkan kembali di dada ibu dan selimuti ibu dan bayi sampai suhu tubuh bayi stabil dan bayi hangat.

- 8) Letakkan ibu dan bayinya dalam satu ruangan bersama agar bayi selalu dalam jangkauan ibu 24 jam dalam sehari sehingga bayi bisa menyusui sesuai keinginannya.

Menurut Depkes (2009), tatalaksana IMD pada persalinan *sectio cesarea*, yaitu:

- 1) Tenaga dan pelayanan kesehatan yang supportif.
- 2) Jika memungkinkan, suhu ruangan *sectio caesarea* adalah 20-25 °C dan disediakan selimut untuk menutupi punggung bayi untuk mengurangi hilangnya panas dari permukaan tubuh bayi.
- 3) Anastesi yang dilakukan untuk ibu merupakan anastesi epidural dan bukan anastesi umum.
- 4) Penatalaksanaan selanjutnya sama dengan tata laksana umum.
- 5) Jika IMD belum terjadi dikamar bersalin, kamar operasi, atau terdapat kondisi yang mengharuskan bayi dipindah sebelum 1 jam, maka bayi tetap diletakkan di atas dada ibu saat dipindahkan ke kamar perawatan atau pemulihan dan menyusui dini dilanjutkan dikamar perawatan ibu atau kamar perawatan.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat IMD pada persalinan *sectio cesarea* adalah:

- 1) Rawat gabung (Rooming in)
- 2) Kondisi sayatan yang ada diperut ibu membuat ibu masih merasakan nyeri di area sayatan dan jahitan perut. Oleh karena itu, ibu muda pasien caesar dapat memberikan ASI pertamanya kepada bayi lebih dari satu jam setelah lahir.
- 3) Kondisi fisik yang lemah akibat pengaruh bius yang diberikan pada saat operasi caesar.

5. Inisiasi Menyusu Dini yang kurang tepat

Secara umum menurut Roesli (2012), praktik IMD yang kurang tepat antara lain:

- a. Setelah lahir, bayi dibaringkan di atas perut ibu dan diselimuti kain kering.
- b. Segera lap bayi dengan kain kering, potong dan ikat tali pusar.
- c. Karena khawatir hipotermi, dibungkus dengan selimut bayi
- d. Bayi dibaringkan di dada ibu sambil dibedong (tanpa menyentuh kulit ibu). Bayi digendong di dada ibu beberapa saat (10-15 menit) (diikat) atau sampai perineum dijahit oleh tenaga medis.
- e. Bayi diangkat, dan disusukan pada ibu dengan cara memasukkan puting ibu ke dalam mulut bayi untuk menyusui.

- f. Setelah itu, bayi dibawa ke ruang transisi atau pemulihan untuk ditimbang, diukur, dicap, didoakan oleh ayah, disuntik vitamin K, dan terkadang diberi obat tetes mata.

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Keberhasilan IMD dipengaruhi oleh adanya dukungan dari keluarga, pengetahuan ibu yang cukup tentang manfaat dari pelaksanaan IMD. Serta sikap, pengetahuan dan motivasi bidan/dokter yang melakukan pertolongan persalinan sendiri. Minimnya pengetahuan dan ketidakmauan orang tua serta tenaga medis untuk melakukan inisiasi menyusu dini masih jarang dilakukan, masih ada orang tua yang tidak yakin bisa. Maupun rasa malu untuk meminta dokter yang membantu persalinan untuk melakukannya (Roesli, 2012).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuwansyah (2017) di PKM Cigasong Kabupaten Majalengka pada 82 Ibu bersalin. Diperoleh hasil bahwa 40,2 % responden tidak melaksanakan IMD. Faktor yang berhubungan bermakna dengan pelaksanaan IMD yaitu : Kondisi bayi, Kondisi ibu, Tempat bersalin, Penolong persalinan, Pengetahuan, Pendidikan, Paritas, dan Sikap.

Pada analisis multivariat factor yang berhubungan bermakna dengan pelaksanaan IMD adalah Sikap ibu, paritas, dan kondisi ibu. Sedangkan faktor paling dominannya adalah kondisi dan sikap ibu dengan Odd Ratio ($p=0,000$, OR = 8,889, 95% CI).

Untuk itu perlu dilakukan penguatan program untuk ketercapaian target IMD yaitu dengan evaluasi secara terus menerus kinerja petugas kesehatan dalam mensosialisasikan pentingnya pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD).

C. Pertanyaan dan Jawaban Seputar IMD

1. Apakah manfaat menyusui bayi sejak kelahirannya ?

Jawab :

Menyusui bayi segera setelah dilahirkan sangat berguna, baik untuk ibu maupun bayinya. Di awal kelahiran, ASI mengandung kolostrum yang banyak mengandung zat kekebalan tubuh dan zat penting lainnya. Selain itu juga dapat merangsang ASI cepat keluar. Sedangkan pada ibu nya, dapat merangsang kontraksi uterus sehingga proses involusi uterus menjadi lebih cepat dan dapat mencegah terjadi perdarahan.

2. Bila terdapat robekan pada jalan lahir dan harus di jahit, apakah IMD harus dihentikan?

Jawab :

Sementara jalan lahir di jahit IMD tidak perlu dihentikan.

3. Setelah lahir, bayi perlu diberi suntikan vitamin K dan tetes mata, bagaimana dengan IMD? Apakah perlu dihentikan?

Jawab :

Sebaiknya dilakukan IMD terlebih dahulu. Tindakan penyuntikan vitamin K dan pemberian tetes mata dapat ditunda dalam 1 jam pertama.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonucci, R., Porcella, A., & Fanos, V. (2009). The infant incubator in the neonatal intensive care unit: Unresolved issues and future developments. *Journal of Perinatal Medicine*, 37(6), 587–598. <https://doi.org/10.1515/JPM.2009.109/MACHINEREADABLECITATION/RIS>
- Choirunisa, S., Adisasmita, A., Izati, Y. N., Pratomo, H., & Iriani, D. (2021). Kangaroo mother care practices for low birthweight newborns in a district hospital in Indonesia. *Child Health Nursing Research*, 27(4), 354. <https://doi.org/10.4094/CHNR.2021.27.4.354>
- Fikawati, S., Syafiq, A., & Karima, K. (2015). *Gizi Ibu dan Bayi*. Raja Grafindo Persada.
- Gebremedhin, M., Ambaw, F., Admassu, E., & Berhane, H. (2015). Maternal associated factors of low birth weight: A hospital based cross-sectional mixed study in Tigray, Northern Ethiopia. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 15(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/S12884-015-0658-1/TABLES/4>
- Hidayat Alimul Aziz. (2008). *Pengantar Ilmu Kesehatan Anak Untuk Pendidikan Kebidanan* (Angriani Rida (Ed.)).
- Hypothermia in Neonates - Pediatrics - MSD Manual Professional Edition*. (n.d.).
- Imdad, A., & Bhutta, Z. A. (2013). Nutritional management of the low birth weight/preterm infant in community settings: a perspective from the developing world. *The Journal of Pediatrics*, 162(3 Suppl). <https://doi.org/10.1016/J.JPEDS.2012.11.060>
- Kebidanan, T. (2017). *MODUL ASUHAN NEONATUS, BAYI, BALITA, DAN ANAK PRA SEKOLAH*. POLTEKKES KEMENKES MEDAN.
- Kemenkes. (2012). *Pedoman pengendalian infeksi saluran pernafasan akut*. Kemenkes RI.
- Lisfasiska, N. M., & Asiyah, S. (2017). Perbedaan Kejadian Perdarahan Dan Infeksi Tali Pusat Yang Diikat Dengan Benang Dan Umbilical Cord Clamp. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 2(1), 61. <https://doi.org/10.32831/jik.v2i1.30>
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 450 / MENKES / SK / IV /2004 tentang Pemberian ASI Secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia, (2004).
- UU Republik Indonesia no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (2009).
- PP Republik Indonesia No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, (2012).
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 15 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehata, (2014).

- Mitayani. (2011). *Asuhan Keperawatan Maternitas*. Salemba Medika.
- Murti, N. N., & Hendriani, D. (2017). Hubungan IMD dengan Laktasi pada Ibu Post Partum Normal di RS Khusus Bersalin Balikpapan Tahun 2016. *Mahakam Midwifery Journal*, 2(1), 33–45.
- Nyandiko, W. M. (2013). Newborn Thermoregulation. *Champlain Maternal Newborn Regional Program (CMNRP)*, June, 1–16.
- Putri, R. H., Surmiasih, S., Kameliawati, F., & Afifah, H. (2020). Inisiasi Menyusu Dini dan Pencapaian Involusi Uterus pada Ibu Postpartum. *Faletehan Health Journal*, 7(03), 149–154. <https://doi.org/10.33746/fhj.v7i03.136>
- Roesli, U. (2012). *Inisiasi Menyusu Dini Plus ASI Eksklusif*. Pustaka Bunda (Group Puspa Swara).
- Sakonidou, S., & Dhaliwal, J. (2015). The management of neonatal respiratory distress syndrome in preterm infants (European Consensus Guidelines—2013 update). *Archives of Disease in Childhood - Education and Practice*, 100(5), 257–259. <https://doi.org/10.1136/ARCHDISCHILD-2014-306642>
- Sari, I. D. (2020). Efektifitas Inisiasi Menyusu Dini terhadap Perubahan Suhu Tubuh pada Bayi Baru lahir. *Jurnal Kebidanan*, 9(1), 30–36.
- Sarwono Prawihardjo. (2010). Ilmu Kebidanan Edisi IV. In *Kesehatan Reproduksi*.
- Sembiring, J. B. (2019). *Buku Ajar Neonatus, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah*. Deepublish Publisher.
- Umrah, A. St. (2018). Pengaruh Pemberian Topikal Asi Terhadap Waktu Perawatan Tali Pusat Pada Bayi Baru Lahir Di Puskesmas Angkona Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur. *Voice of Midwifery*, 6(08), 38–48. <https://doi.org/10.35906/vom.v6i08.22>
- Wulandari Sri R.Made, dkk. (2021). *Modul Postnatal Education Package* (Wulandari (Ed.); Cetakan I). CV.Literasi Nusantara Abadi.
- Yitayew, Y. A., Aitaye, E. B., Lechissa, H. W., & Gebeyehu, L. O. (2020). Neonatal Hypothermia and Associated Factors among Newborns Admitted in the Neonatal Intensive Care Unit of Dessie Referral Hospital, Amhara Region, Northeast Ethiopia. *International Journal of Pediatrics*, 2020. <https://doi.org/10.1155/2020/3013427>
- Yuwansyah, Y. (2017). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (Imd) Pada Ibu Bersalin Di Wilayah Kerja Uptd Puskesmas Cigasong Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Factors Associated To the Implementation of Early Breastfeeding Initiation (Ebi) on Po. *Jurnal Bidan "Midwife Journal*, 3(01), 73–82.

BAB 3

ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI BARU LAHIR

DENGAN MASALAH

Kadek Yuke Widyantari, S.SiT., M.Keb



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

BAB 3

ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI BARU LAHIR DENGAN MASALAH

Kadek Yuke Widyantari, S.SiT., M.Keb

A. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

1. Definisi

Menurut World Health Organization (WHO) (2004) dalam Cutland *et al.*, (2017) berat lahir bayi adalah berat badan pertama yang dicatat setelah lahir dan idealnya diukur dalam jam-jam pertama setelah lahir, sebelum terjadi penurunan berat badan pasca kelahiran yang signifikan. Berat badan lahir rendah (BBLR) didefinisikan sebagai berat lahir kurang dari 2500 gram.

Berat badan lahir rendah merupakan masalah kesehatan masyarakat yang dapat dicegah. Ini adalah penentu penting kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta konsekuensi jangka panjang seperti timbulnya penyakit tidak menular dalam perjalanan hidup. Sejumlah besar kematian dan kesakitan dapat dicegah dengan mengatasi faktor-faktor yang terkait dengan berat badan lahir rendah, sehingga penting untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian BBLR pada bayi (Anil *et al.*, 2020). Berat badan lahir rendah adalah indikator kesehatan masyarakat yang berharga dari kesehatan ibu, nutrisi, pemberian layanan kesehatan, dan kemiskinan. Neonatus dengan berat lahir rendah memiliki risiko kematian >20 kali lebih besar dari pada neonatus dengan berat lahir >2500 g (Cutland *et al.*, 2017).

2. Faktor Resiko terjadinya BBLR

a. Faktor Maternal

- 1) Riwayat penyakit medis (hipertensi, diabetes, infeksi)
- 2) Anemia sebelum atau selama masa kehamilan
- 3) Kurangnya asupan besi folat
- 4) Tinggi badan ibu kurang dari 150 cm
- 5) Rendahnya pertambahan berat badan dalam kehamilan
- 6) Konsumsi alkohol dan rokok
- 7) Usia ibu ≤ 20 tahun
- 8) Rendahnya kunjungan ANC (Antenatal Care)

b. Faktor Janin

- 1) *Intrauterine Growth Restriction* (IUGR)
- 2) Cacat bawaan

c. Faktor Kehamilan

- 1) Kehamilan ganda
- 2) Perdarahan antepartum

- 3) Kelainan plasenta
- 4) Persalinan premature

(Desta *et al.*, 2020 ; Anil *et al.*, 2020 ; Gebremedhin *et al.*, 2015).

3. Klasifikasi

Klasifikasi BBLR menurut WHO (2004) dalam Cutland *et al.*, (2017), adalah sebagai berikut:

- a. BBLR (Berat Badan Lahir Rendah, <2500 gram)
- b. BBLSR (Berat Badan Lahir Sangat Rendah, <1500 gram)
- c. BBLER (Berat Badan Lahir Ekstrem Rendah, <1000 gram)

4. Masalah pada bayi BBLR

Selama periode baru lahir, bayi BBLR menunjukkan peningkatan risiko untuk mengalami hipoglikemia, hipotermia, hiperkoagulabilitas, hiperbilirubinemia, hipotensi, necrotizing enterocolitis, sindrom gangguan pernapasan, skor Apgar yang lebih rendah, asidosis arteri umbilikalis, lebih banyak dilakukan intubasi dan komplikasi selama persalinan dan sekitar 20 kali peningkatan risiko kematian neonatal daripada bayi yang lahir dengan berat badan normal (Negrato & Gomes, 2013).

5. Perawatan Bayi BBLR

a. Menjaga Suhu Tubuh

Dalam perawatan bayi BBLR hal penting untuk menjaga suhu tubuh bayi agar tetap stabil, bayi BBLR rentan mengalami hipotermi. Hipotermi ini disebabkan karena pusat pengaturan suhu tubuh (*thermoregulasi*) belum berfungsi secara optimal seperti bayi berat lahir normal, jaringan lemak yang relatif rendah, dan permukaan tubuh luasnya relative besar (Sukarni *et al.*, 2014).

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kehilangan panas pada bayi BBLR adalah *Kangaroo Mother Care* (KMC). *Kangaroo mother care* melibatkan kontak kulit ke kulit (*skin-to-skin contact*) sejak dini, terus menerus, dan berkelanjutan antara ibu dan bayinya, pemberian ASI yang sering dan eksklusif, serta pemulangan dini dari rumah sakit. Ini adalah standar perawatan terkini untuk bayi berat lahir rendah dan bayi prematur (Choirunisa *et al.*, 2021). Pada beberapa kasus, bayi dengan BBLR memerlukan perawatan inkubator selama menjalani rawat inap di rumah sakit. Penggunaan inkubator sebagai upaya menjaga stabilitas suhu tubuh dan penatalaksanaan hipotermi pada bayi BBLR, bayi premature, dan bayi baru lahir sakit sudah menjadi perawatan standar di rumah sakit (Antonucci *et al.*, 2009).

b. Kebutuhan Nutrisi

Pemberian ASI eksklusif melindungi ibu dan bayinya dan telah terbukti mengurangi morbiditas dan mortalitas pada masa bayi, termasuk bayi dengan berat badan lahir rendah. Menyusui eksklusif harus dipromosikan, dan

suplemen makanan alternatif yang sesuai harus diberikan ketika menyusui tidak memungkinkan (Imdad & Bhutta, 2013).

B. Hipotermi

1. Definisi

Hipotermia neonatal adalah penurunan progresif suhu aksila bayi baru lahir (suhu $<36,5^{\circ}\text{C}$). Ini adalah masalah global pada neonatus yang lahir baik di rumah sakit maupun di rumah, tetapi prevalensinya lebih tinggi di negara berkembang ($>90\%$). Meskipun hipotermia jarang menjadi penyebab langsung kematian, hipotermia berkontribusi terhadap sebagian besar kematian neonatal secara global (Yitayew *et al.*, 2020).

Neonatus rentan terhadap kehilangan panas yang cepat dan akibat hipotermia karena rasio luas permukaan terhadap massa tubuh yang besar, penurunan lemak subkutan, kulit yang belum matang, kandungan air tubuh yang tinggi, metabolisme yang kurang berkembang. Neonatus hipotermia memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami hipoglikemia, sindrom gangguan pernapasan, ikterus, dan asidosis metabolik (Nyandiko, 2013)

2. Klasifikasi

Menurut WHO (1997) dalam Yitayew *et al.*, (2020) hipotermi dikategorikan sebagai berikut:

- Hipotermia ringan (36°C – $36,4^{\circ}\text{C}$)
- Hipotermia sedang (32°C – $35,9^{\circ}\text{C}$), dan
- Hipotermia berat ($<32^{\circ}\text{C}$)

3. Faktor Resiko Hipotermi

Hipotermia dapat disebabkan oleh faktor lingkungan, gangguan yang merusak termoregulasi tubuh bayi (misalnya, sepsis, perdarahan intrakranial, penarikan obat), atau kombinasinya. Faktor risiko hipotermia meliputi prematuritas, bayi BBLR, persalinan di daerah dengan suhu lingkungan di bawah tingkat yang direkomendasikan, pakaian neonatus yang tidak memadai, tidak adanya *skin-to-skin contact*, tidak dilakukannya inisiasi menyusui dini, *hipertensi* pada ibu, persalinan sesar, dan skor Apgar rendah (Nyandiko, 2013 ; Arcangela, 2022 ; Yitayew *et al.*, 2020).

4. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan hipotermi pada bayi baru lahir adalah dengan menghangatkan kembali dalam inkubator atau *infant warmer*. Neonatus harus dipantau dan diobati sesuai kebutuhannya, misalnya neonatus dengan hipoglikemia, hipoksemia, dan apnea. Kondisi yang mendasari seperti sepsis, penarikan obat, atau perdarahan intrakranial mungkin memerlukan pengobatan khusus.

C. Ikterus Neonatorum

1. Definisi

Ikterus neonatorum atau hiperbilirubinemia neonatal terjadi akibat peningkatan total serum bilirubin (TSB) dan secara klinis bermanifestasi sebagai perubahan warna kekuningan pada kulit, sklera, dan membran mukosa. Dalam banyak kasus, kondisi kuning pada bayi adalah kondisi ringan, sementara, dan dapat sembuh sendiri dan disebut sebagai Ikterus fisiologis. Namun, sangat penting untuk membedakannya dari bentuk yang lebih parah yang disebut Ikterus patologis. Kegagalan dalam mengidentifikasi dan mengobati dapat menyebabkan ensefalopati bilirubin dan gejala sisa neurologis terkait (Ansong-Assoku *et al.*, 2022).

2. Jenis-jenis Ikterus Neonatorum

Dalam Ullah *et al.*, (2016) dijelaskan bahwa terdapat lima jenis ikterus neonatorum, yaitu sebagai berikut:

a. Ikterus Fisiologis

Ini adalah jenis ikterus bayi baru lahir yang paling banyak terjadi dan tidak memiliki konsekuensi yang serius. Ikterus fisiologis biasanya muncul pada bayi berusia 24-72 jam dan antara hari ke-4 dan ke-5 dapat dianggap sebagai puncaknya pada neonatus cukup bulan dan pada prematur pada hari ke-7, ikterus ini akan menghilang pada hari ke 10-14. Bilirubin tak terkonjugasi adalah bentuk utama dan biasanya kadar serumnya kurang dari 15 mg/dl. Berdasarkan rekomendasi terbaru dari *The American Academy of Pediatrics* (AAP), kadar bilirubin 17-18 mg/dl dapat diterima sebagai kadar bilirubin normal pada bayi baru lahir yang sehat.

b. Ikterus Patologis

Tingkat bilirubin dengan penyimpangan dari kisaran normal dan membutuhkan intervensi akan digambarkan sebagai ikterus patologis. Ikterus patologis biasanya ditandai dengan munculnya jaundice pada bayi usia 24 jam atau usia 2 minggu. Munculnya penyakit kuning dalam 24 jam karena peningkatan serum bilirubin melebihi 5 mg/dl/hari, kadar puncak lebih tinggi dari kisaran normal yang diharapkan, adanya penyakit kuning klinis lebih dari 2 minggu dan bilirubin terkonjugasi (urin berwarna gelap yang menodai pakaian) akan dikategorikan di bawah penyakit kuning jenis ini.

c. Ikterus Menyusui

Bayi yang disusui secara eksklusif memiliki pola fisiologis yang berbeda untuk penyakit kuning dibandingkan dengan bayi yang disusui secara artifisial. Penyakit kuning pada bayi yang disusui biasanya muncul antara usia 24-72 jam, memuncak pada usia 5-15 hari dan menghilang pada minggu ketiga kehidupan. Dalam kasus bayi baru lahir yang disusui, penyakit kuning ringan dapat terjadi 10-14 hari setelah lahir atau dapat terjadi kembali selama masa menyusui.

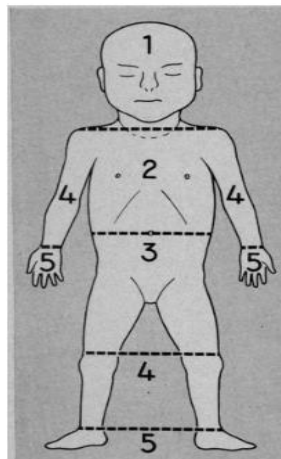
Penurunan frekuensi menyusui dikaitkan dengan ikterus fisiologis yang berlebihan. Salah satu prosedur penting untuk mengatasi penyakit kuning pada bayi cukup bulan yang sehat adalah dorongan ibu untuk menyusui bayinya setidaknya 10–12 kali per hari.

d. Ikterus Hemolitik

Penyebab paling umum dari ikterus hemolitik meliputi (a) penyakit hemolitik Rh, (b) inkompatibilitas ABO dan (c) defisiensi Glukosa-6-fosfat dehidrogenase (G-6-PD) dan inkompatibilitas golongan darah minor.

3. Pemeriksaan Klinis

Untuk mengetahui tingkat ikterus, dapat digunakan derajat pewarnaan dermal oleh Kramer. Pewarnaan kulit pada bayi baru lahir berkembang ke arah cephalo-caudal. Bayi yang baru lahir harus diperiksa di siang hari yang cerah. Dokter harus memucatkan kulit dengan tekanan digital dan warna dasar kulit dan jaringan subkutan harus dicatat. Bayi baru lahir yang terdeteksi kulit kuning di luar paha harus segera mendapatkan konfirmasi laboratorium untuk kadar bilirubin (Ullah *et al.*, 2016).



Gambar 3.1 Zona dermal ikterus cephalo-pedal progresif.

Sumber: Kramer (1969)

Derajat 1 (Kepala dan leher), 2 (Batang ke umbilikus), 3 (Selangkangan termasuk paha atas), 4 (Lutut dan siku ke mata kaki dan pergelangan tangan), 5 (Kaki dan tangan termasuk telapak tangan dan telapak kaki).

4. Penatalaksanaan

Menurut Ennever JF. (1990) dalam (Ullah *et al.*, 2016) pilihan pengobatan untuk ikterus meliputi fototerapi (konvensional, intensif dan transfusi tukar) dan pengobatan farmakologis (fenobarbiton, *intravenous immunoglobulins* (IVIG), metalloporphyrins dan pengobatan lanjutan).

D. Hipoglikemia

1. Definisi

Nilai ambang hipoglikemia adalah 40 mg/dL selama 24 jam pertama pada bayi bergejala. Pada bayi tanpa gejala, nilai ini dianggap 25 mg/dL selama 0-4 jam, 35 mg/dL selama 4-24 jam, 50 mg/dL setelah 24 jam dan 60 mg/dL setelah 48 jam. Hipoglikemia adalah salah satu masalah metabolisme bayi baru lahir yang paling penting dan paling umum terjadi karena menimbulkan risiko cedera neurologis, jika berkepanjangan dan berulang. Oleh karena itu, bayi baru lahir yang memiliki risiko hipoglikemia harus segera diberi makan setelah melahirkan dan kadar glukosa darah harus diukur dengan interval 2-3 jam dari menit ke-30 setelah menyusui (Aliefendioğlu *et al.*, 2018).

2. Faktor Resiko

a. Faktor risiko ibu

- 1) Diabetes pregestasional atau gestasional
- 2) Preeklampsia/eklampsia, hipertensi terkait kehamilan
- 3) Pengobatan medis (β -blocker, agen hipoglikemik oral, tokolitik β -agonis, late antepartum dan intrapartum dextrose)

b. Faktor risiko bayi

- 1) Prematuritas
 - 2) IUGR (*Intrauterine growth retardation*)
 - 3) BBLR (Berat Badan Lahir Rendah)
 - 4) Postmaturitas
 - 5) Asfiksia perinatal, sindrom aspirasi mekonium (MAS)
 - 6) Infeksi
 - 7) Polisitemia
 - 8) Hipotermia
 - 9) Penggunaan obat-obatan (Indometasin IV)
 - 10) Penyakit hemolitik imun (inkompatibilitas Rh)
 - 11) Penyakit jantung bawaan
 - 12) Gangguan endokrin
 - 13) Fitur khusus pada temuan pemeriksaan fisik
 - 14) Riwayat saudara kandung dengan hipoglikemia
 - 15) Malnutrisi
- (Aliefendioğlu *et al.*, 2018).

3. Tanda dan Gejala Hipoglikemi

- Letargi (lesu)
- Iritabilitas (lekas marah)
- Gelisah
- Koma, kejang, hipotonia
- Payah dalam mengisap

- Takipnea
- Apnea
- Bradikardia
- Sianosis
- Kepucatan
- Hipotermia
- Teriakan suara bernada tinggi
- Gerakan mata yang tidak normal

4. Tatalaksana

Tingkat yang ditargetkan dengan pengobatan dianggap 50 mg/dL pada 48 jam pertama setelah melahirkan sebelum menyusui, 60 mg/dL setelah 48 jam pada bayi dengan risiko tinggi dan di atas 70 mg/dL pada bayi dengan hipoglikemia permanen. Dalam kasus di mana kadar glukosa darah di bawah nilai ambang batas dan tidak dapat ditingkatkan dengan pemberian makan, infus glukosa 6-8 mg/kg/menit harus dimulai. Jika gejala menyertai, bolus mini 10% dekstrosa (2 ml/kg/menit) harus menyertai. Peningkatan (2 mg/kg/menit) harus dilakukan, jika tingkat target tidak dapat dicapai dan pengurangan (2 ml/kg/menit) harus dilakukan, jika nutrisi dan stabilisasi tersedia. Infus harus dihentikan, jika laju infus menurun hingga 3-5 mg/kg/menit. Jika perlu, sampel darah harus diambil selama hipoglikemia dalam hal diagnosis banding dan penyelidikan harus dilakukan setelah periode puasa 6 jam pada bayi yang diberi makan enteral dan kapan saja ketika glukosa plasma <50 mg/dL pada bayi yang menerima infus parenteral. Bayi hipoglikemik dalam kelompok risiko yang infusnya dihentikan dapat dipulangkan, jika kadar glukosa plasma ditemukan pada tingkat target dua kali sebelum menyusui dan bayi dengan hipoglikemia permanen, berat atau resisten dapat dipulangkan, jika plasma kadar glukosa >60 mg/dL setelah puasa 6 jam (Aliefendioğlu *et al.*, 2018).

E. Gangguan Nafas

1. Definisi

Gangguan pernapasan pada bayi baru lahir dikenali sebagai satu atau lebih tanda peningkatan kerja pernapasan, seperti takipnea, hidung melebar, retraksi dada, atau mendengus. Sindrom gangguan pernapasan neonatal (RDS) terjadi dari defisiensi surfaktan, karena produksi surfaktan yang tidak memadai, atau inaktivasi surfaktan dalam konteks paru-paru yang belum matang. Prematuritas memengaruhi kedua faktor ini, sehingga berkontribusi langsung terhadap RDS (Reuter *et al.*, 2014).

2. Faktor Resiko

- a. Prematuritas
- b. Cairan ketuban bernoda mekonium

- c. Persalinan dengan operasi caesar
- d. Diabetes gestasional
- e. Korioamnionitis ibu
- f. Oligohidramnion
- g. Kelainan struktural paru (Reuter *et al.*, 2014).

3. Tatalaksana

- a. Kortikosteroid antenatal
- b. Pemantauan oksigenasi dan ventilasi
- c. Bantuan ventilasi neonatus
- d. Terapi surfaktan eksogen
- e. Perawatan suportif, termasuk termoregulasi, dukungan nutrisi, manajemen cairan dan elektrolit, terapi antibiotik, dll (Carlo *et al.*, 2014 ; Sakonidou & Dhaliwal, 2015).

DAFTAR PUSTAKA

- Aliefendioğlu, D., Çoban, A., Hatipoğlu, N., Ecevit, A., Arısoy, A. E., Yeşiltepe, G., Baş, F., Bideci, A., & Özek, E. (2018). Management of hypoglycemia in newborn: Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies consensus report. *Turkish Archives of Pediatrics/Türk Pediatri Arşivi*, 53(Suppl 1), S224. <https://doi.org/10.5152/TURKPEDIATRIARS.2018.01820>
- Anil, K. C., Basel, P. L., & Singh, S. (2020). Low birth weight and its associated risk factors: Health facility-based case-control study. *PLoS ONE*, 15(6). <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0234907>
- Ansong-Assoku, B., Shah, S. D., Adnan, M., & Ankola, P. A. (2022). Neonatal Jaundice. *Alzheimer's and Dementia: Diagnosis, Assessment and Disease Monitoring*, 13(3), 1–4.
- Antonucci, R., Porcella, A., & Fanos, V. (2009). The infant incubator in the neonatal intensive care unit: Unresolved issues and future developments. *Journal of Perinatal Medicine*, 37(6), 587–598. <https://doi.org/10.1515/JPM.2009.109/MACHINEREADABLECITATION/RIS>
- Anwar, A., & Dharmayanti, I. (2016). Pneumonia pada Anak Balita di Indonesia Pneumonia among. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 29, 359–365.
- Baggett, K. M., Davis, B., Sheeber, L., Miller, K., Leve, C., Mosley, E. A., Landry, S. H., & Feil, E. G. (2021). Optimizing social-emotional-communication development in infants of mothers with depression: Protocol for a randomized controlled trial of a mobile intervention targeting depression and responsive parenting. *JMIR Research Protocols*, 10(8). <https://doi.org/10.2196/31072>
- Carlo, W. A., Polin, R. A., Papile, L. A., Tan, R., Kumar, P., Benitz, W., Eichenwald, E., Cummings, J., & Baley, J. (2014). Respiratory Support in Preterm Infants at Birth. *Pediatrics*, 133(1), 171–174. <https://doi.org/10.1542/PEDS.2013-3442>
- Choirunisa, S., Adisasmita, A., Izati, Y. N., Pratomo, H., & Iriani, D. (2021). Kangaroo mother care practices for low birthweight newborns in a district hospital in Indonesia. *Child Health Nursing Research*, 27(4), 354. <https://doi.org/10.4094/CHNR.2021.27.4.354>
- Cutland, C. L., Lackritz, E. M., Mallett-Moore, T., Bardají, A., Chandrasekaran, R., Lahariya, C., Nisar, M. I., Tapia, M. D., Pathirana, J., Kochhar, S., & Muñoz, F. M. (2017). Low birth weight: Case definition & guidelines for data collection, analysis, and presentation of maternal immunization safety data. *Vaccine*, 35(48Part A), 6492. <https://doi.org/10.1016/J.VACCINE.2017.01.049>
- Desta, S. A., Damte, A., & Hailu, T. (2020). Maternal factors associated with low birth weight in public hospitals of Mekelle city, Ethiopia: a case-control study. *Italian Journal of Pediatrics*, 46(1). <https://doi.org/10.1186/S13052-020-00890-9>

- Fikawati, S., Syafiq, A., & Karima, K. (2015). *Gizi Ibu dan Bayi*. Raja Grafindo Persada.
- Gebremedhin, M., Ambaw, F., Admassu, E., & Berhane, H. (2015). Maternal associated factors of low birth weight: A hospital based cross-sectional mixed study in Tigray, Northern Ethiopia. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 15(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/S12884-015-0658-1/TABLES/4>
- Herman, H. (2020). the Relationship of Family Roles and Attitudes in Child Care With Cases of Caput Succedaneum in RSUD Labuang Baji, Makassar City in 2018. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(2), 49–52. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i2.49>
- Hidayat Alimul Aziz. (2008). *Pengantar Ilmu Kesehatan Anak Untuk Pendidikan Kebidanan* (Angriani Rida (Ed.)).
- Hypothermia in Neonates - Pediatrics - MSD Manual Professional Edition*. (n.d.).
- Imdad, A., & Bhutta, Z. A. (2013). Nutritional management of the low birth weight/preterm infant in community settings: a perspective from the developing world. *The Journal of Pediatrics*, 162(3 Suppl). <https://doi.org/10.1016/J.JPEDI.2012.11.060>
- Kebidanan, T. (2017). *MODUL ASUHAN NEONATUS, BAYI, BALITA, DAN ANAK PRA SEKOLAH*. POLTEKKES KEMENKES MEDAN.
- Kemenkes. (2012). *Pedoman pengendalian infeksi saluran pernafasan akut*. Kemenkes RI.
- Kramer, L. I. (1969). Advancement of dermal icterus in the jaundiced newborn. *American Journal of Diseases of Children* (1960), 118(3), 454–458. <https://doi.org/10.1001/ARCHPEDI.1969.02100040456007>
- Lisfasiska, N. M., & Asiyah, S. (2017). Perbedaan Kejadian Perdarahan Dan Infeksi Tali Pusat Yang Diikat Dengan Benang Dan Umbilical Cord Clamp. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 2(1), 61. <https://doi.org/10.32831/jik.v2i1.30>
- Makhfirah, N., Fatimatuazzahra, C., Mardina, V., & Fanani Hakim, R. (2020). PEMANFAATAN BAHAN ALAMI SEBAGAI UPAYA PENGHAMBAT *Candida albicans* PADA RONGGA MULUT. *Jurnal Jeumpa*, 7(2), 400–413. <https://doi.org/10.33059/jj.v7i2.3005>
- Martua, Y. S. (2021). Analisis Faktor – Faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Sepsis Neonatorum di RSUD Taluk Kuantan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 13(1), 55–63. <https://doi.org/10.37012/jik.v13i1.459>
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 450 / MENKES / SK / IV /2004 tentang Pemberian ASI Secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia, (2004).
- UU Republik Indonesia no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (2009).
- PP Republik Indonesia No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, (2012).

- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 15 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan, (2014).
- Mitayani. (2011). *Asuhan Keperawatan Maternitas*. Salemba Medika.
- Murti, N. N., & Hendriani, D. (2017). Hubungan IMD dengan Laktasi pada Ibu Post Partum Normal di RS Khusus Bersalin Balikpapan Tahun 2016. *Mahakam Midwifery Journal*, 2(1), 33–45.
- Nasution Yusnita Eva. (2022). *Monograf Penulisan Imunisasi Dasar Lengkap* (Nasution Bincar (Ed.)). PT. Inovasi Pertama Internasional.
- Negrato, C. A., & Gomes, M. B. (2013). Low birth weight: Causes and consequences. *Diabetology and Metabolic Syndrome*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/1758-5996-5-49/METRICS>
- Novita Sari, S. (2017). ANALISIS FAKTOR RISIKO KEMATIAN BAYI PENDERITA TETANUS NEONATORUM DI PROVINSI JAWA TIMUR Risk Analyses Factor of Infant Mortality Caused by Tetanus Neonatorum in East Java. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, Volume 5 N(August 2017), 195–206. <https://doi.org/10.20473/jbe.v5i2.2017.195-206>
- Nyandiko, W. M. (2013). Newborn Thermoregulation. *Champlain Maternal Newborn Regional Program (CMNRP)*, June, 1–16.
- Pricilia, V. (2016). Gambaran Kejadian Infeksi Bayi Baru Lahir di Bagian Perinatologi RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2012. *NERS Jurnal Keperawatan*, 9(1), 66. <https://doi.org/10.25077/njk.9.1.66-75.2013>
- Pusponegoro, T. S. (2000). *Sepsis pada Neonatus (Sepsis Neonatal)*. 2, 96–102.
- Putri, R. H., Surmiasih, S., Kameliawati, F., & Afifah, H. (2020). Inisiasi Menyusu Dini dan Pencapaian Involusi Uterus pada Ibu Postpartum. *Faletehan Health Journal*, 7(03), 149–154. <https://doi.org/10.33746/fhj.v7i03.136>
- Rachman, A., Dharma Artana, W., & Sukmawati, M. (2017). Prevalens meningitis neonatal dan faktor-faktor yang memengaruhi pada bayi klinis sepsis di ruang NICU RSUP Sanglah Denpasar. *Medicina Journal*, 48(2), 113. <https://doi.org/10.15562/medicina.v48i2.38>
- Rahmawati Dewi Septi dkk. (2019). *Pedoman Praktis Imunisasi pada Anak* (Tim UB press (Ed.); Cetakan I). UB Press.
- Reuter, S., Moser, C., & Baack, M. (2014). Respiratory Distress in the Newborn. *Pediatrics in Review*, 35(10), 417. <https://doi.org/10.1542/PIR.35-10-417>
- Roesli, U. (2012). *Inisiasi Menyusu Dini Plus ASI Eksklusif*. Pustaka Bunda (Group Puspa Swara).
- Sakonidou, S., & Dhaliwal, J. (2015). The management of neonatal respiratory distress syndrome in preterm infants (European Consensus Guidelines—2013 update).

- Archives of Disease in Childhood - Education and Practice*, 100(5), 257–259.
<https://doi.org/10.1136/ARCHDISCHILD-2014-306642>
- Salendu, P. M. (2013). Sepsis Neonatorum Dan Pneumonia Pada Bayi Aterm. *Jurnal Biomedik (Jbm)*, 4(3), 175–179. <https://doi.org/10.35790/jbm.4.3.2012.2037>
- Sampurna A.T Mahendra. (2020). *Lindungi Diri Dengan Imunisasi* (Abadi Anas (Ed.)). Airlangga University Press.
- Sari, I. D. (2020). Efektifitas Inisiasi Menyusu Dini terhadap Perubahan Suhu Tubuh pada Bayi Baru lahir. *Jurnal Kebidanan*, 9(1), 30–36.
- Sari Indria Lia. (2020). *Buku Ajar Imunisasi Bayi*. Media Sains Indonesia.
- Sarwono Prawihardjo. (2010). Ilmu Kebidanan Edisi IV. In *Kesehatan Reproduksi*.
- Sembiring, J. B. (2019). *Buku Ajar Neonatus, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah*. Deepublish Publisher.
- Ullah, S., Rahman, K., & Hedayati, M. (2016). Hyperbilirubinemia in Neonates: Types, Causes, Clinical Examinations, Preventive Measures and Treatments: A Narrative Review Article. *Iranian Journal of Public Health*, 45(5), 558.
- Umrah, A. St. (2018). Pengaruh Pemberian Topikal Asi Terhadap Waktu Perawatan Tali Pusat Pada Bayi Baru Lahir Di Puskesmas Angkona Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur. *Voice of Midwifery*, 6(08), 38–48.
<https://doi.org/10.35906/vom.v6i08.22>
- Wulandari Sri R.Made, dkk. (2021). *Modul Postnatal Education Package* (Wulandari (Ed.); Cetakan I). CV.Literasi Nusantara Abadi.
- Yitayew, Y. A., Aitaye, E. B., Lechissa, H. W., & Gebeyehu, L. O. (2020). Neonatal Hypothermia and Associated Factors among Newborns Admitted in the Neonatal Intensive Care Unit of Dessie Referral Hospital, Amhara Region, Northeast Ethiopia. *International Journal of Pediatrics*, 2020. <https://doi.org/10.1155/2020/3013427>
- Yuwansyah, Y. (2017). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (Imd) Pada Ibu Bersalin Di Wilayah Kerja Uptd Puskesmas Cigasong Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Factors Associated To the Implementation of Early Breastfeeding Initiation (Ebi) on Po. *Jurnal Bidan "Midwife Journal"*, 3(01), 73–82.

BAB 4

IMUNISASI

Baiq Dika Fatmasari, S.ST.,M.Keb



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

BAB 4

IMUNISASI

Baiq Dika Fatmasari, S.ST.,M.Keb

A. Definisi Imunisasi

Imunisasi jika dilihat dari istilah berasal dari kata Imun berarti kebal atau resisten. Oleh sebab itu imunisasi sendiri bisa diartikan seseorang yang mendapatkan kekebalan dari suatu penyakit tertentu. Seseorang dikatakan anti atau kebal terhadap penyakit tertentu belum tentu kebal terhadap penyakit lainnya. (Sampurna A.T Mahendra, 2020)

Imunisasi adalah suatu upaya untuk memberikan respon terhadap imun dalam arti meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu terpajan dalam penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit yang ringan. Karena proses pembentukan kekebalan tubuh yang berperan untuk mencegah dan melindungi tubuh dari ancaman kerusakan terutama penyakit infeksi. Imunisasi akan meningkatkan kekebalan tubuh bayi dan anak sehingga mampu melawan suatu penyakit dengan cara dicegah dengan vaksin tersebut. (Nasution Yusnita Eva, 2022)

Imunisasi juga dalam definisi lain merupakan salah satu cara untuk memberikan kekebalan pada bayi dan anak terhadap berbagai penyakit diharapkan dengan imunisasi bayi dan anak tetap tumbuh dalam keadaan sehat. Secara alamiah tubuh sudah memiliki pertahanan terhadap berbagai kuman yang masuk. Pertahanan tubuh tersebut meliputi pertahanan nonspesifik. Seperti komplemen dan makrofag ini yang pertama kali akan memberikan peran Ketika ada kuman yang masuk ke dalam tubuh. (sebelum itu ada mekanisme pertahanan fisik berupa kulit, selaput lender, dan lain-lain). Setelah itu kuman harus menghadapi pertahanan tubuh yang kedua, yaitu pertahanan tubuh spesifik yang terdiri dari system pertahanan tubuh humoral dan seluler. Pertahanan tubuh humoral dilakukan oleh sel limfosit B dan hanya dapat bereaksi apabila mikroorganisme sampai di cairan tubuh. System pertahanan humoral akan menghasilkan zat yang disebut immunoglobulin (IgA, IgM, IgG, IgE, IgH). Sistem Pertahanan tubuh dilakukan limfosit T dan bereaksi apabila virus menempel pada sel. Dalam pertahanan tubuh yang spesifik terutama sel B, selanjutnya akan menghasilkan satu sel yang disebut *cell memory*. Sel ini akan berguna dan sangat cepat bereaksi apabila ada kuman yang sudah pernah masuk ke dalam tubuh. Kondisi inilah yang digunakan dalam prinsip Imunisasi. (Hidayat Alimul Aziz, 2008).

B. Tujuan Pemberian Imunisasi

1. Tercapainya jangkauan imunisasi dasar lengkap (IDL) Pada bayi sesuai tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
2. Tercapainya target imunisasilanjutan pada anak dibawah usia dua tahun dan pada anak usia sekolah dasar serta Wanita usia subur (WUS)
3. Terlaksannya pemberian imunisasi yang aman melalui manajemen limbah medis yang sesuai dengan standar (*Safety Injection Practise and waste disposal management*)
4. Menghilangkan penyakit tertentu pada sekelompok masyarakat (populasi)
5. Menghilangkan penyakit tertentu dari dunia (misanya Cacar) hanya mungkin pada penyakit yang ditularkan melalui manusia (Misalnya difteri)
6. Menjadikan anak kebal terhadap penyakit sehingga dapat menurunkan angka morbiditas dan mortalitas serta mengurangi kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

C. Macam-Macam Imunisasi

Berdasarkan proses atau mekanisme dari pertahanan tubuh anak, imunisasi dibagi menjadi dua, imunisasi aktif dan imunisasi pasif.

1. Imunisasi aktif merupakan pemberian zat sebagai antigen yang diharapkan akan terjadi suatu proses infeksi buatan, sehingga tubuh bisa mengalami reaksi imunologi spesifik yang akan menghasilkan respons seluler dan humoral serta dihasilkan cell memory. Jika benar-benar terjadi infeksi maka tubuh secara cepat dapat merespons. Dalam imunisasi aktif terdapat empat macam kandungan dalam setiap vaksinnnya, yang bisa dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Antigen merupakan bagian dari vaksin yang berfungsi sebagai zat atau mikroba guna terjadinya semacam infeksi buatan (beupa polisakarida, virus yang dilemahkan atau bakteri yang dimatikan)
 - b. Pelarut dapat berupa air steril atau berupa cairan kultur jaringan
 - c. Preservative, stabiliser dan antibiotic yang berguna untuk mencegah tumbuhnya mikroba sekaligus untuk stabilisasi antigen
 - d. Adjuvans yang terdiri atas garam aluminium yang berfungsi untuk meningkatkan imunogenitas antigen.
2. Imunisasi pasif merupakan pemberian zat (immunoglobulin), yaitu suatu zat yang dihasilkan melalui suatu proses infeksi yang dapat berasal dari plasma manusia atau binatang yang digunakan untuk mengatasi mikroba yang diduga sudah masuk dalam tubuh yang terinfeksi.

D. Jenis Imunisasi Dasar

Di Indonesia terdapat jenis imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah (Imunisasi Dasar) ada juga yang hanya dianjurkan. Imunisasi wajib di Indonesia sebagaimana lebih diwajibkan oleh WHO ditambah dengan hepatitis B. Sedangkan imunisasi yang hanya dianjurkan oleh pemerintah dapat digunakan untuk mencegah suatu kejadian yang luar biasa atau penyakit endemic atau untuk kepentingan tertentu misalnya jamaah haji yang disuntikan (Rahmawati Dewi Septi dkk, 2019)

Keberhasilan pemberian imunisasi pada anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya terdapat tingginya kadar antibody pada saat dilakukan imunisasi, potensi antigen yang di suntikkan waktu pemberian imunisasi dan status nutrisi terutama kecukupan protein karena kadar protein diperlukan untuk mensintesis antibody. Mengingat efektif dan tidaknya imunisasi tersebut dapat bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Sehingga kekebalan tubuh dapat diharapkan dari diri anak. (Nasution Yusnita Eva, 2022)

Beberapa imunisasi dasar yang diwajibkan oleh pemerintah yang biasa kita sebut dengan imunisasi dasar lengkap terdiri dari:

1. BCG (*bacilli Calmette Guerin*)

Imunisasi BCG ini sendiri berguna untuk mencegah penyakit *tuberculosis* berat, antara lain yang banyak di Indonesia yaitu TB Paru, imunisasi ini sebaiknya di berikan sebelum bayi berusia 2-3 bulan. Dosis untuk bayi kurang setahun adalah 0.05 ml dan anak 0.10 ml. Injeksi secara intra dermal di bawah lengan kanan atas. BCG ini tidak menyebabkan demam dan tidak dianjurkan BCG ulangan. Pada bekas suntikan BCG akan meninggalkan jaringan perut pada bekas suntikan.

2. Hepatitis B

Imunisasi hepatitis B ini diberikan sedini mungkin setelah bayi lahir. Pemberian imunisasi hepatitis B pada bayi lahir harus melihat pada ibu apakah ibu tersebut mengandung virus hepatitis B aktif atau tidak pada saat melahirkan. Ulangan hepatitis B dapat dipertimbangkan pada umur 10-12 tahun. Dan yang perlu diperhatikan jika bayi tersebut tidak diberikan Hepatitis B sampai usia 5 tahun maka anak tersebut harus diberikan secepatnya.

3. DPT (*Difteri Pertusis Tetanus*)

Imunisasi DPT untuk mencegah Difteri, pertusis dan tetanus, yang menyebabkan bakteri difteri *Corynebacteriumdiphtheriae* yang sangat menular yang dimulai dengan gangguan tenggorokan dan dengan cepat menimbulkan gangguan pernafasan itu disebabkan karena di tenggorokan terjadi selaput yang menyumbat jalan nafas sehingga akibat yang paling berbahaya menyebabkan kematian, selain itu juga menimbulkan toksin atau racun yang berbahaya untuk jantung. Imunisasi DPT dasar diberikan 3 kali sejak anak berumur 2 bulan dengan interval pemberian 4-6 minggu. DPT 1 diberikan umur

2-4 bulan. DPT 2 umur 3-5 bulan, DPT 3 umur 4-6 bulan. Imunisasi DPT pada bayi tiga kali (3 dosis) akan memberikan imunitas sampai 3 tahun

4. Polio

Imunisasi dasar yang dilakukan pemberian 4 kali vaksin ini diberikan 2 tetes per oral dengan interval tidak kurang dari dua minggu. Mengingat Indonesia sendiri merupakan daerah endemic polio, sesuai pedoman dari PPI bahwa imunisasi polio diberikan segera setelah lahir pada kunjungan pertama, dan yang biasa dilakukan nanti untuk waktu pemberian bersamaan dengan pemberian imunisasi DPT.

5. Campak

Campak adalah penyakit yang sangat menular yang dapat disebabkan oleh virus campak. Sistem penularan dari virus campak ini melalui udara maupun kontak langsung dengan penderita, gejala yang sering terjadi demam, batuk pilek dan bercak-bercak merah pada permukaan kulit 3-5 hari setelah anak menderita demam. Bercak mulai tubuh pada pipi lalu ke telinga yang kemudian menjalar ke seluruh tubuh. Vaksin campak diberikan dalam dosis 0,5 ml pada usia 9 bulan serta program pemerintah campak lanjutan diberikan pada usia 18 bulan.

6. Imunisasi Hib

Imunisasi Hib (*Haemophilus influenzae* tipe b) merupakan imunisasi baru yang diprogramkan pemerintah yang diberikan untuk mencegah terjadinya penyakit influenza tipe b. Vaksin ini berbentuk polisakrida murni, pada pemberian imunisasi awal dilakukan pemberian sebanyak 3 kali suntikan interval 2 bulan, kemudian boosternya dapat diberikan pada usia 18 bulan (Sari Indria Lia, 2020)

7. Imunisasi IPV (*Inactivated Poliovirus Vaccine*)

Jenis vaksin ini adalah jenis vaksin baru yang diberikan Pemerintah Indonesia. IPV dihasilkan dengan cara membiakan virus dengan media pembiakan, kemudian dibuat tidak aktif, untuk kegunaan virus ini sama untuk mencegah virus polio. Vaksin ini diberikan di usia 4 bulan (Wulandari Sri R. Made, 2021)



Gambar 4.1
Waktu Pemberian Imunisasi Dasar

Tabel 4.1
Kontraindikasi Vaksin Dasar Lengkap

Jenis Imunisasi	Kontraindikasi
Semua vaksin	Terjadi reaksi anafilaksis terhadap vaksin tersebut penyakit sedang atau berat dengan atau tanpa demam
DPT	Ensefalopati dalam 7 hari pasca dosis DPT sebelumnya
Polio	Infeksi HIV, gangguan imunodefisiensi yang tidak diketahui seperti tumor hematologis dan padat, imunodefisiensi kongenital, dan terapi imunosupresi jangka panjang
HiB	Tidak teridentifikasi
Hepatitis B	Reaksi anafilaksis terhadap ragi roti

Tabel 4.2
Kejadian Ikutan Pascaimunisasi Dasar Dan Penanganan

Jenis Imunisasi	Efek Samping	Penanganan
DPT	Umumnya demam dalam 24-48 jam, sakit kemerahan pada bekas suntikan, bengkak rewel mengantuk serta anoreksia	Jelaskan efek samping dan pemberian vaksin yang da, apabila terjadi demam dapat diberikan antipiretik atau apabila nyeri dapat digunakan asetaminofen atau konsultasi dokter
Polio	Paralisis karena vaksin jarang terjadi dalam 2 bulan imunisasi	
Campak	Anoreksia, malaise, ruam. Dan demam sampai 10 hari	

E. Jenis Imunisasi Rekomendasi IDAI Tahun 2020

Pemberian imunisasi yang di rekomendasikan IDAI (Ikatan Dokter anak Indonesia) pada pertengahan Desember 2020, satuan tugas imunisasi mempublikasi rekomendasi baru yaitu mulai anak usia 0-18 tahun. Jadwal imunisasi terbaru ini menggantikan jadwal imunisasi 2017 yang sebelumnya dipakai. Secara umum jadwal imunisasi terbaru ini tidak jauh berbeda dengan yang terdahulu, namun ada poin-poin keterangan yang mengalami perubahan misalnya pada dosis, frekuensi dan batas usia anak yang paling optimal untuk memperoleh imunisasi.

Imunisasi		Umur																	
		Bulan												Tahun					
		Lahir	1	2	3	4	5	6	9	12	15	18	24	3	5	6	7	8	9
Hepatitis B		1		2	3	4						5							
Polio		0	1	2	3							4							
BCG		1 kali																	
DTP			1	2	3							4			5				Td / Tdap
Hib			1	2	3							4							
PCV			1		2						4								
Rotavirus			1		2			3 (p)											
Influenza								1						Diulang setiap tahun 1 kali					
MR / MMR								MR				MR / MMR			MR / MMR				
JE								1					2						
Varisela											2 kali, interval 6 minggu - 3 bulan								
Hepatitis A											2 kali, interval 6 - 36 bulan								
Tifoid													1						Diulang setiap 3 tahun 1 kali
HPV																		2 kali	
Dengue																		3 kali, interval 6 bulan	

Cara membaca kolom umur: misal (2) berarti umur 2 bulan (60 hari) s.d. 2 bulan 29 hari (89 hari).
 Rekomendasi imunisasi berlaku setelah diterbitkan di Sari Pediatri. Dapat diakses pada website IDAI (<http://idai.or.id/public-artides/klinik/imunisasi/jadwal-imunisasi-anak-idsai.html>)

Primer
Catch-up
Booster
Daerah Endemis

Untuk menerapkan jadwal imunisasi dengan benar perlu dibaca keterangan di bawah ini dan uraian lengkap di majalah Sari Pediatri

- Vaksin hepatitis B (HB)** monovalen sebaiknya diberikan kepada bayi segera setelah lahir sebelum berumur 24 jam, diakhiri penyuntikan vitamin K1 minimal 30 menit sebelumnya. Bayi dengan berat lahir kurang dari 2000g, imunisasi hepatitis B sebaiknya ditunda sampai berumur 1 bulan atau lebih, kecuali ibu HBsAg positif dan bayi bugar berikan imunisasi HB segera setelah lahir tetapi tidak dihitung sebagai dosis primer. Bayi lahir dari ibu HBsAg positif, segera berikan vaksin HB dan imunoglobulin hepatitis B (HBIG) pada ekstremitas yang berbeda, maksimal dalam 7 hari setelah lahir. Imunisasi HB selanjutnya diberikan bersama DTPa atau DTP.
- Vaksin polio 0 (nol)**: sebaiknya diberikan segera setelah lahir. Apabila lahir di fasilitas kesehatan berikan bOPV-0 saat bayi pulang atau pada kunjungan pertama. Selanjutnya berikan bOPV atau IPV bersama DTPa atau DTP. Vaksin IPV minimal diberikan 2 kali sebelum berumur 1 tahun bersama DTPa atau DTP.
- Vaksin BCG**: sebaiknya diberikan segera setelah lahir atau segera mungkin sebelum bayi berumur 1 bulan. Bila berumur 3 bulan atau lebih BCG diberikan bila uji tuberkulin negatif. Bila uji tuberkulin tidak tersedia, BCG dapat diberikan. Bila timbul reaksi lokal cepat pada minggu pertama dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk diagnosis tuberkulosis.
- Vaksin DTP**: dapat diberikan mulai umur 6 minggu berupa vaksin DTPa atau DTP. Vaksin DTPa diberikan pada umur 2, 3, 4 bulan atau 2, 4, 6 bulan. Booster pertama diberikan pada umur 18 bulan. Booster berikutnya diberikan pada umur 5-7 tahun atau pada program BIAS kelas 1. Umur 7 tahun atau lebih menggunakan vaksin Td atau Tdap. Booster selanjutnya pada umur 10-18 tahun atau pada program BIAS kelas 5. Booster Td diberikan setiap 10 tahun.
- Vaksin pneumokokus (PCV)**: diberikan pada umur 2, 4 dan 6 bulan dengan booster pada umur 12-15 bulan. Jika belum diberikan pada umur 7-12 bulan, berikan PCV 2 kali dengan jarak 1 bulan dan booster setelah umur 12 bulan dengan jarak 2 bulan dari dosis sebelumnya. Jika belum diberikan pada umur 1-2 tahun berikan PCV 2 kali dengan jarak minimal 2 bulan. Jika belum diberikan pada umur 2-5 tahun, PCV10 diberikan 2 kali dengan jarak 2 bulan. PCV13 diberikan 1 kali.
- Vaksin rotavirus monovalen**: diberikan 2 kali, dosis pertama mulai umur 6 minggu, dosis kedua dengan interval minimal 4 minggu, harus selesai pada umur 24 minggu.
- Vaksin rotavirus pentavalen**: diberikan 3 kali, dosis pertama 6-12 minggu, dosis kedua dan ketiga dengan interval 4 sampai 10 minggu, harus selesai pada umur 32 minggu.
- Vaksin influenza**: diberikan mulai umur 6 bulan, diulang setiap tahun. Pada umur 6 bulan sampai 8 tahun imunisasi pertama 2 dosis dengan interval minimal 4 minggu. Umur ≥ 9 tahun, imunisasi pertama 1 dosis.
- Vaksin MR / MMR**: pada umur 9 bulan berikan vaksin MR. Bila sampai umur 12 bulan belum mendapat vaksin MR, dapat diberikan MMR. Umur 18 bulan berikan MR atau MMR. Umur 5-7 tahun berikan MR (dalam program BIAS kelas 1) atau MMR.
- Vaksin Japanese encephalitis (JE)**: diberikan mulai umur 9 bulan di daerah endemis atau yang akan bepergian ke daerah endemis. Untuk perlindungan jangka panjang dapat diberikan booster 1-2 tahun kemudian.
- Vaksin varisela**: diberikan mulai umur 12-18 bulan. Pada umur 1-12 tahun diberikan 2 dosis dengan interval 6 minggu sampai 3 bulan. Umur 13 tahun atau lebih dengan interval 4 sampai 6 minggu.
- Vaksin hepatitis A**: diberikan 2 dosis mulai umur 1 tahun, dosis ke-2 diberikan 6 bulan sampai 12 bulan kemudian.
- Vaksin tifoid polysakarida**: diberikan mulai umur 2 tahun dan diulang setiap 3 tahun.
- Vaksin human papilloma virus (HPV)**: diberikan pada anak perempuan umur 9-14 tahun 2 kali dengan jarak 6-15 bulan (atau pada program BIAS kelas 5 dan 6). Umur 15 tahun atau lebih diberikan 3 kali dengan jadwal 0, 1, 6 bulan (vaksin bivalent) atau 0, 2, 6 bulan (vaksin quadrivalent).
- Vaksin dengue**: diberikan pada anak umur 9-16 tahun dengan seropositif dengue yang dibuktikan adanya riwayat pernah dirawat dengan diagnosis dengue (pemeriksaan antigen NS-1 dan atau uji serologi IgM/IgG anti-dengue positif) atau dibuktikan dengan pemeriksaan serologi IgG anti-dengue positif.

Gambar 4.2
Jadwal Imunisasi Rekomendasi Dokter

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A., & Dharmayanti, I. (2016). Pneumonia pada Anak Balita di Indonesia Pneumonia among. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 29, 359–365.
- Choirunisa, S., Adisasmita, A., Izati, Y. N., Pratomo, H., & Iriani, D. (2021). Kangaroo mother care practices for low birthweight newborns in a district hospital in Indonesia. *Child Health Nursing Research*, 27(4), 354. <https://doi.org/10.4094/CHNR.2021.27.4.354>
- Cutland, C. L., Lackritz, E. M., Mallett-Moore, T., Bardaji, A., Chandrasekaran, R., Lahariya, C., Nisar, M. I., Tapia, M. D., Pathirana, J., Kochhar, S., & Muñoz, F. M. (2017). Low birth weight: Case definition & guidelines for data collection, analysis, and presentation of maternal immunization safety data. *Vaccine*, 35(48Part A), 6492. <https://doi.org/10.1016/J.VACCINE.2017.01.049>
- Hidayat Alimul Aziz. (2008). *Pengantar Ilmu Kesehatan Anak Untuk Pendidikan Kebidanan* (Angriani Rida (Ed.)).
- Kebidanan, T. (2017). *MODUL ASUHAN NEONATUS, BAYI, BALITA, DAN ANAK PRA SEKOLAH*. POLTEKKES KEMENKES MEDAN.
- Kemenkes. (2012). *Pedoman pengendalian infeksi saluran pernafasan akut*. Kemenkes RI.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 450 / MENKES / SK / IV /2004 tentang Pemberian ASI Secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia, (2004).
- UU Republik Indonesia no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (2009).
- PP Republik Indonesia No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, (2012).
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 15 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehata, (2014).
- Mitayani. (2011). *Asuhan Keperawatan Maternitas*. Salemba Medika.
- Nasution Yusnita Eva. (2022). *Monograf Penulisan Imunisasi Dasar Lengkap* (Nasution Bincar (Ed.)). PT. Inovasi Pertama Internasional.
- Nyandiko, W. M. (2013). Newborn Thermoregulation. *Champlain Maternal Newborn Regional Program (CMNRP)*, June, 1–16.
- Pusponegoro, T. S. (2000). *Sepsis pada Neonatus (Sepsis Neonatal)*. 2, 96–102.
- Rachman, A., Dharma Artana, W., & Sukmawati, M. (2017). Prevalens meningitis neonatal dan faktor-faktor yang memengaruhi pada bayi klinis sepsis di ruang NICU

- RSUP Sanglah Denpasar. *Medicina Journal*, 48(2), 113. <https://doi.org/10.15562/medicina.v48i2.38>
- Rahmawati Dewi Septi dkk. (2019). *Pedoman Praktis Imunisasi pada Anak* (Tim UB press (Ed.); Cetakan I). UB Press.
- Reuter, S., Moser, C., & Baack, M. (2014). Respiratory Distress in the Newborn. *Pediatrics in Review*, 35(10), 417. <https://doi.org/10.1542/PIR.35-10-417>
- Roesli, U. (2012). *Inisiasi Menyusu Dini Plus ASI Eksklusif*. Pustaka Bunda (Group Puspa Swara).
- Sakonidou, S., & Dhaliwal, J. (2015). The management of neonatal respiratory distress syndrome in preterm infants (European Consensus Guidelines—2013 update). *Archives of Disease in Childhood - Education and Practice*, 100(5), 257–259. <https://doi.org/10.1136/ARCHDISCHILD-2014-306642>
- Sampurna A.T Mahendra. (2020). *Lindungi Diri Dengan Imunisasi* (Abadi Anas (Ed.)). Airlangga University Press.
- Sari, I. D. (2020). Efektifitas Inisiasi Menyusu Dini terhadap Perubahan Suhu Tubuh pada Bayi Baru lahir. *Jurnal Kebidanan*, 9(1), 30–36.
- Sari Indria Lia. (2020). *Buku Ajar Imunisasi Bayi*. Media Sains Indonesia.
- Sarwono Prawihardjo. (2010). Ilmu Kebidanan Edisi IV. In *Kesehatan Reproduksi*.
- Sembiring, J. B. (2019). *Buku Ajar Neonatus, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah*. Deepublish Publisher.
- Ullah, S., Rahman, K., & Hedayati, M. (2016). Hyperbilirubinemia in Neonates: Types, Causes, Clinical Examinations, Preventive Measures and Treatments: A Narrative Review Article. *Iranian Journal of Public Health*, 45(5), 558.
- Wulandari Sri R.Made, dkk. (2021). *Modul Postnatal Education Package* (Wulandari (Ed.); Cetakan I). CV.Literasi Nusantara Abadi.

BAB 5

INFEKSI PADA NEONATUS DAN PENCEGAHANNYA

Bdn.Selasih Putri Isnawati Hadi, S.Tr.Keb.,M.Tr.Keb



BAB 5

INFEKSI PADA NEONATUS DAN PENCEGAHANNYA

Bdn.Selasih Putri Isnawati Hadi, S.Tr.Keb.,M.Tr.Keb

A. Deskripsi

Infeksi yang terjadi pada neonatus merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan karena menjadi salah satu penyebab tingginya angka kesakitan maupun angka kematian bayi baru lahir di seluruh belahan dunia. Sebagaimana kita mengetahui, diawal kehidupan seorang neonatus baru beradaptasi kehidupan yang awalnya dalam intra uterin yang selalu dalam kondisi bersih dan sterial, saat dilahirkan di ekstra uterin kondisi ini membuat neonatus terpapar dengan berbagai bakteri dan virus yang bisa saja saat kita tidak melakukan pelayanan optimal, hal ini akan mengganggu kesehatannya (Kebidanan, 2017).

Infeksi sering terjadi ini menjadi suatu masalah yang gawat pada neonatus. Data Bank Dunia menunjukkan Angka Kematian Neonatal (usia 0-28 hari) di Indonesia masih terdapat 11,7 dari 1.000 bayi lahir hidup di tahun 2021 yang berarti bahwa ada 11-12 bayi neonatal yang meninggal di setiap 1.000 bayi yang lahir. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena adanya infeksi. Bahkan menurut data WHO memperkirakan ada sekitar 4 juta anak yang meninggal setiap tahunnya karena infeksi, terutama di negara berkembang.

Banyak sekali tanda gejala yang sering muncul seperti malas minum, gelisah, rewel, muntah, diare, berat badan yang turun drastis, frekuensi nafas yang semakin meningkat, bahkan perdarahan (Mitayani, 2011). Secara umum infeksi pada neonatus dibagi menjadi 2 yakni infeksi ringan seperti infeksi pada umbilikus, moniliiasis sedangkan infeksi berat seperti sepsis neonatorum, meningitis, pneumonia neonatal, dan tetanus neonatal (Pricilia, 2016)

B. Uraian Materi

1. Pengertian Neonatus



Gambar 5.1

Bayi baru lahir sering dikenal dengan istilah neonatus yakni bayi yang baru saja mengalami proses kelahiran berusia 0-28 hari yang tumbuh dan melakukan proses penyesuaian diri dari intra uterin ke ekstra uterin (Herman, 2020).

Adapun ciri bayi yang sehat dan normal setelah lahir antara lain:

- a. Lahir dalam kondisi usia kehamilan matang (aterm) yakni usia kehamilan 37-42 minggu
- b. Berat badan lahir 2500-4000 gram
- c. Panjang lahir 48-52 cm
- d. Lingkar dada 30-38 cm
- e. Lingkar kepala 33-35 cm
- f. Lingkar lengan 11-12 cm
- g. Denyut jantung 120-160x/menit
- h. Kulitnya kemerahan
- i. APGAR Skore > 7
- j. Gerakannya aktif dan menangis kuat
- k. Pada laki-laki kematangan ditandai dengan testis yang berada pada skrotum dan penis yang berlubang sedangkan genetalia sedangkan pada perempuan kematangan ditandai dengan labia mayora menutupi labia minora.
- l. Refleks pada bayi normal seperti refleks rooting dan refleks sucking sudah terbentuk dengan baik.

2. Klasifikasi Neonatus

Adapun klasifikasi neonatus terbagi dalam beberapa:

a. Neonatus menurut usia gestasinya

- 1) Kurnag bulan yakni usia lahir saat usia kehamilan < 37 minggu
- 2) Cukup Bulan yakni usia lahir saat usia kehamilan 37-42 minggu
- 3) Lebih Bulan yakni usia lahir saat usia kehamilan 42 minggu atau lebih

b. Neonatus menurut berat badan lahir

- 1) Berat lahir rendah jika berat badan lahir <2500 gram
- 2) Berat lahir cukup jika berat badan lahir 2500 – 4000 gram
- 3) Berat badan lebih jika berat badan lahir >4000 gram

3. Infeksi pada Neonatus

a. Pengertian infeksi pada neonatus

Infeksi pada neonatus merupakan suatu sindroma klinis dari suatu penyakit sistemik yang dikarenakan akibat dari infeksi terutama di awal kehidupan, hal ini karena adanya beberapa paparan mikroorganisme seperti

virus, bakteri, jamur, protozoa yang dapat membuat neonatus dan bayi terganggu kesehatannya.

b. Klasifikasi

1) Menurut Waktu Kejadian

a) Infeksi dini

Yakni infeksi yang terjadi dalam 7 hari pertama kehidupan neonatus. Pada kasus ini biasanya diakibatkan karena cairan amnion ataupun adanya organisme patogen yang berada di jalan lahir.

b) Infeksi lanjutan

Yakni terjadi saat neonatus melewati minggu pertama kehidupannya yang diakibatkan oleh paparan organisme yang ada disekitar lingkungan tempat tinggal dan perawatan bayi.

2) Menurut besarnya masalah

a) Infeksi ringan

(1) Infeksi pada Umbilikus



Gambar 5.2

Selama di fase kehamilan, tali pusat berfungsi sebagai penghubung kehidupan antara ibu dan anak (Lisfasiska & Asiyah, 2017). Setelah neonatus lahir, maka tali pusat yang menghubungkan antara neonatus dengan plasenta ibunya dipotong (Umrah, 2018). Saat ini lah rawan terjadi infeksi yang dikenal dengan omphalitis yakni suatu infeksi yang terjadi pada umbilikus serta jaringan di sekitarnya, yang terjadi terutama pada periode neonatal (Pricilia, 2016). Hal ini dikarenakan segera setelah melahirkan normal, kulit bayi yang baru lahir termasuk pada tali pusat dapat akan diinvasi oleh bakteri terutama oleh bakteri nonpathogenic (non-infeksi penyebab) seperti *staphylococci* dan *difteri basil*. Bakteri patogen seperti *coliform* dan *streptococci* mungkin juga ada pada kulit dan bisa masuk kedalam tali pusat yang menyebabkan infeksi untuk itu membutuhkan perawatan yang baik dan benar untuk meminimalkan infeksi ini (Umrah, 2018). Adapun tanda terjadinya

Infeksi pada Umbilikus antara lain tampak disekitar umbilikus terdapat kemerahan, terdapat pus yang berbau busuk, bayi demam, bengkak dan nyeri.

(2) Moniliasis



Gambar 5.3

Candida albicans merupakan salah satu flora normal yang paling banyak ditemukan pada rongga mulut, kulit, membran mukosa, saluran pencernaan, saluran pernapasan serta vagina. Penyakit yang disebabkan oleh *candida albicans* yaitu penyakit kandidiasis oral (moniliasis) (Makhfirah et al., 2020). Tanda yang sering muncul adalah tampak adanya bercak yang berwarna putih di area mulut maupun lidah, kulit di sudut-sudut mulut pecah-pecah serta nampak ada kemerahan di rongga mulut.

b) Infeksi berat

(1) Sepsis Neonatorum



Gambar 5.4

Terjadinya kasus sepsis pada neonatus ini diperkirakan 1-10 per 1000 kelahiran hidup. Kejadian ini biasanya terjadi pada 5-7 hari pertama dengan organisme penyebab didapat dari intrapartum atau melalui saluran genital ibu yang dikenal dengan sepsis cepat. Adapun sepsis lambat jika infeksi ini terjadi setelah bayi berumur 7 hari atau lebih, yang mudah menjadi berat dan sering menjadi meningitis. Sepsis nosokomial terutama terjadi pada bayi berat lahir sangat rendah atau bayi kurang bulan dengan angka kematian yang sangat tinggi untuk itu perlu ada

tindakan pencegahan infeksi yang baik dan benar saat kontak dengan bayi (Pusponegoro, 2000). Faktor penyebab sepsis antara lain faktor ibu misalnya persalinan preterm, terjadi ketuban pecah dini 18-24 jam, adanya infeksi pada saluran kemih ibu dan faktor sosial ekonomi serta faktor bayi seperti BBLR, kelainan bawaan, asfiksia (Martua, 2021; Salendu, 2013). Adapun tanda yang sering muncul saat neonatus terkena sepsis antara lain anak demam, sering muntah, leher kaku, detak jantung cepat, rewel serta sering menggigil.

(2) Meningitis

Meningitis adalah peradangan pada meninges atau lapisan pelindung di sekitar otak manusia. Angka kejadian meningitis pada neonatus dengan klinis sepsi diperkirakan hampir mencapai 50% (Rachman et al., 2017). Adapun faktor penyebabnya antara lain bayi kurang bulan, BBLR, KPD, malnutrisi serta bayi dengan penyakit penyerta seperti pneumonia neonatal (Rachman et al., 2017). Adapun tanda yang sering muncul saat neonatus terkena meningitis antara lain anak demam, tampak kuning, sering muntah, neonatus lemas, detak jantung cepat atau melambat.

(3) Pneumonia Neonatal



Gambar 5.5

Pneumonia merupakan salah satu infeksi yang paling sering terjadi pada neonatus dan salah satu penyumbang kematian perinatal (Salendu, 2013). Pneumonia ini adalah suatu penyakit infeksi pada saluran nafas akut bagian bawah (Martua, 2021). Penyebab pneumoni antara lain bakteri, virus, jamur, paparan bahan kimia atau kerusakan fisik dari paru-paru, maupun pengaruh tidak langsung dari penyakit lain (Anwar & Dharmayanti, 2016). Infeksi ini ditandai dengan munculnya gejala seperti batuk dan atau kesulitan bernapas seperti frekuensi napas

cepat, dan terlihat adanya tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam (Kemenkes, 2012)

(4) Tetanus Neonatal



Gambar 5.6

Tetanus Neonatorum merupakan suatu infeksi pada bayi yang berusia < 28 hari yang disebabkan oleh bakteri *Clostridium tetani* yang masuk ke tubuh melalui luka (Novita Sari, 2017). Faktor penyebabnya antara lain faktor paritas, status imunisasi TT ibu hamil, perawatan tali pusat, dan kecepatan pertolongan rumah sakit. Adapun tanda yang sering muncul jika neonatus terkena tetanus antara lain mulut kaku dan seolah terkunci, tidak mau menyusu, otot wajah dan rahang kaku dan sering terkadi kejang.

c. Penyebab Infeksi pada Neonates

Penyakit infeksi dapat berasal dari bakteri, virus, parasit maupun jamur (Salendu, 2013). Seperti *Streptokokus Grup B* (GBS), kuman usus Gram negatif, terutama *Escherisia coli*, *Listeria monocytogenes*, *Stafilokokus*, *Streptokokus* lainnya (termasuk Enterokokus), kuman anaerob, dan haemophilus influenzae. Sedangkan penyebab sepsis nosokomial adalah *Stafilokokus* (terutama *Staphylococcus epidermidis*), kuman Gram negatif (*Pseudomonas*, *Klebsiella*, *Serratia*, dan *Proteus*), dan jamur (Pusponegoro, 2000)

d. Faktor-faktor Predisposisi Infeksi pada Neonatus

Faktor risiko terjadinya infeksi antara lain dikarenakan faktor ibu dan faktor bayi. Faktor ibu bisa disebabkan ketuban pecah dini (KPD) >18 jam, ibu yang sedang demam saat intrapartum >38°C, terjadinya korioamnionitis, ketuban berbau, keputihan yang tidak diobati, serta ibu yang dicurigai infeksi saluran kemih (ISK) serta persalinan yang masih kurang bulan. Sedangkan faktor bayi seperti denyut jantung janin (DJJ) >160x/menit, skor APGAR rendah (menit 1 skor <5 dan menit 5 skor <7), BBLSR (<1500 gram), bayi kembar, atau karena faktor invasif.

4. Pencegahan Infeksi pada Neonatus

Pencegahan infeksi pada neonatus merupakan salah satu penerapan 5 benang merah yakni aspek ketiga yang berhubungan dengan asuhan persalinan yang bersih serta aman sebagai salah satu upaya untuk melindungi diri baik ibu maupun neonatus. Upaya pencegahan infeksi merupakan suatu tindakan atau usaha untuk meminimalkan masuknya mikroorganisme ke dalam jaringan tubuh bayi sehingga dapat terhindar dari suatu penyakit infeksi. Upaya ini dapat dilakukan saat pertolongan persalinan kelahiran bayi agar ibu, bayi yang baru lahir, keluarga serta penolong persalinan terhindar dari infeksi.

Pencegahan infeksi secara luas dikenal dengan istilah *universal precaution* yang mencakup semua aspek kehidupan serta lingkungan dalam upaya pencegahan seseorang ataupun masyarakat terhadap penularan suatu penyakit.

Adapun cara untuk pencegahan infeksi antara lain (Sembiring, 2019):

- 1) Mencuci tangan dengan sabun dan dibawah air mengalir sebelum dan sesudah kontak dengan bayi
- 2) Menggunakan APD lengkap seperti sepatu boot, sarung tangan, kacamata, celemek saat kontak dengan bayi
- 3) Semua peralatan dalam kondisi steril
- 4) Menganjurkan ibu dan keluarga untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan
- 5) Menjaga bayi dari paparan orang yang terkena infeksi dan memastikan untuk cuci tangan sebelum kontak dengan bayi

DAFTAR PUSTAKA

- Aliefendioğlu, D., Çoban, A., Hatipoğlu, N., Ecevit, A., Arısoy, A. E., Yeşiltepe, G., Baş, F., Bideci, A., & Özek, E. (2018). Management of hypoglycemia in newborn: Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies consensus report. *Turkish Archives of Pediatrics/Türk Pediatri Arşivi*, 53(Suppl 1), S224. <https://doi.org/10.5152/TURKPEDIATRIARS.2018.01820>
- Anil, K. C., Basel, P. L., & Singh, S. (2020). Low birth weight and its associated risk factors: Health facility-based case-control study. *PLoS ONE*, 15(6). <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0234907>
- Ansong-Assoku, B., Shah, S. D., Adnan, M., & Ankola, P. A. (2022). Neonatal Jaundice. *Alzheimer's and Dementia: Diagnosis, Assessment and Disease Monitoring*, 13(3), 1–4.
- Kebidanan, T. (2017). *MODUL ASUHAN NEONATUS, BAYI, BALITA, DAN ANAK PRA SEKOLAH*. POLTEKKES KEMENKES MEDAN.
- Kemenkes. (2012). *Pedoman pengendalian infeksi saluran pernafasan akut*. Kemenkes RI.
- Lisfasiska, N. M., & Asiyah, S. (2017). Perbedaan Kejadian Perdarahan Dan Infeksi Tali Pusat Yang Diikat Dengan Benang Dan Umbilical Cord Clamp. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 2(1), 61. <https://doi.org/10.32831/jik.v2i1.30>
- Martua, Y. S. (2021). Analisis Faktor – Faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Sepsis Neonatorum di RSUD Taluk Kuantan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 13(1), 55–63. <https://doi.org/10.37012/jik.v13i1.459>
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 450 / MENKES / SK / IV / 2004 tentang Pemberian ASI Secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia, (2004).
- UU Republik Indonesia no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (2009).
- Novita Sari, S. (2017). ANALISIS FAKTOR RISIKO KEMATIAN BAYI PENDERITA TETANUS NEONATORUM DI PROVINSI JAWA TIMUR Risk Analyses Factor of Infant Mortality Caused by Tetanus Neonatorum in East Java. *Jurnal Berkala Epidemiologi, Volume 5 N*(August 2017), 195–206. <https://doi.org/10.20473/jbe.v5i2.2017.195-206>
- Pricilia, V. (2016). Gambaran Kejadian Infeksi Bayi Baru Lahir di Bagian Perinatologi RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2012. *NERS Jurnal Keperawatan*, 9(1), 66. <https://doi.org/10.25077/njk.9.1.66-75.2013>
- Pusponegoro, T. S. (2000). *Sepsis pada Neonatus (Sepsis Neonatal)*. 2, 96–102.
- Rachman, A., Dharma Artana, W., & Sukmawati, M. (2017). Prevalens meningitis neonatal dan faktor-faktor yang memengaruhi pada bayi klinis sepsis di ruang NICU RSUP Sanglah Denpasar. *Medicina Journal*, 48(2), 113. <https://doi.org/10.15562/medicina.v48i2.38>

- Sarwono Prawihardjo. (2010). Ilmu Kebidanan Edisi IV. In *Kesehatan Reproduksi*.
- Sembiring, J. B. (2019). *Buku Ajar Neonatus, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah*. Deepublish Publisher.
- Umrah, A. St. (2018). Pengaruh Pemberian Topikal Asi Terhadap Waktu Perawatan Tali Pusat Pada Bayi Baru Lahir Di Puskesmas Angkona Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur. *Voice of Midwifery*, 6(08), 38–48. <https://doi.org/10.35906/vom.v6i08.22>
- Wulandari Sri R.Made, dkk. (2021). *Modul Postnatal Education Package* (Wulandari (Ed.); Cetakan I). CV.Literasi Nusantara Abadi.

BAB 6

ASUHAN KEBIDANAN KOMPLEMENTER

PADA BAYI BARU LAHIR

Ardiyanti Hidayah, SST., Bd., M. Kes



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

BAB 6

ASUHAN KEBIDANAN KOMPLEMENTER PADA BAYI BARU LAHIR

Ardiyanti Hidayah, SST., Bd., M. Kes

A. Konsep Dasar Asuhan Kebidanan Komplementer

Terapi komplementer merupakan kelompok dari bermacam-macam sistem pengobatan, praktek, perawatan, dan produk yang secara umum tidak menjadi bagian dari pengobatan konvensional (Perry, Potter, 2009).

Pemanfaatan dari Terapi alternatif komplementer frekuensinya mengalami peningkatan pesat di dunia. Perkembangan frekuensi yang meningkat telah tercatat di negara Afrika dengan kisaran populasi global sebanyak 20% sampai dengan 80% (Amira dan Okubadejo 2007).

Data Kemenkes tahun 2011 menunjukkan pembuktian 80% masyarakat Afrika memakai pengobatan alternatif dan komplementer untuk perawatan kesehatan primer. Bahkan di Indonesia sendiri terdapat 40% dari jumlah seluruh masyarakat dan 70% penduduk pedesaan di Indonesia memakai pengobatan alternatif dan komplementer (Kamaluddin, 2010.)

Menurut Permenkes Republik Indonesia nomor 1109 tahun 2007 menjelaskan bahwa terapi komplementer merupakan terapi yang mencakup kuratif, rehabilitatif, promotif, dan preventif yang bisa diaplikasikan oleh tim kesehatan dengan keamanan dan efektivitas tinggi. Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan pengobatan komplementer menjadi salah satu bagian pelayanan kesehatan dan perawat sebagai bagian dari tim kesehatan yang dipersilakan untuk mengaplikasikan pengobatan komplementer.

Sedangkan menurut WHO pengobatan komplementer merupakan pengobatan non konvensional yang bukan berasal dari negara yang bersangkutan. Sebagai contoh jamu di Indonesia misalnya, bukan termasuk pengobatan komplementer tetapi merupakan pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional yang dimaksud yaitu pengobatan yang sudah dari zaman dahulu digunakan dan diturunkan secara turun-temurun pada suatu negara.

Pengertian terapi komplementer menurut kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI terapi adalah usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit, pengobatan penyakit, perawatan penyakit. Komplementer adalah bersifat melengkapi, bersifat menyempurnakan titik pengobatan komplementer dilakukan dengan tujuan melengkapi pengobatan medis konvensional dan bersifat rasional yang tidak bertentangan dengan nilai dan hukum kesehatan di Indonesia.

Standar praktik pengobatan komplementer telah diatur dalam peraturan menteri kesehatan republik Indonesia. Terapi komplementer adalah sebuah

kelompok dari macam-macam sistem pengobatan dan perawatan kesehatan, praktek dan produk yang secara umum tidak menjadi bagian dari pengobatan konvensional.

Komplementer adalah penggunaan terapi tradisional ke dalam pengobatan modern titik terminologi ini dikenal sebagai terapi modalitas atau aktivitas yang menambahkan pendekatan ortodoks dalam pelayanan kesehatan. Terapi komplementer juga ada yang menyebutnya dengan pengobatan holistik. Pendapat ini didasari oleh bentuk terapi yang mempengaruhi individu secara menyeluruh yaitu sebuah keharmonisan individu untuk mengintegrasikan pikiran badan, dan jiwa dalam kesatuan fungsi (Sticker, 2018).

Terapi komplementer dikenal dengan penggabungan terapi tradisional di dalam pengobatan modern. Terminologi ini dikenal sebagai terapi modalitas atau aktivitas yang menambahkan pendekatan ortodoks dalam pemberian, pelayanan kesehatan. Terapi komplementer juga disebut dengan pengobatan holistik titik pendapat ini didasari oleh bentuk terapi yang digunakan, mempengaruhi individu secara menyeluruh yaitu sebuah keharmonisan individu untuk mengintegrasikan pikiran badan dan jiwa dalam kesatuan fungsi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terapi komplementer merupakan pengembangan terapi tradisional dan ada yang diintegrasikan dengan terapi modern yang mempengaruhi keharmonisan individu dari aspek biologis psikologis, dan spiritual. Hasil terapi yang telah terintegrasi tersebut ada yang telah lulus uji klinis sehingga sudah disamakan dengan obat modern. Kondisi ini sesuai dengan prinsip keperawatan yang memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang holistik (bio, psiko, sosial, dan spiritual).

B. Asuhan Komplementer Pada Bayi dan Balita

Perkembangan trend perawatan khusus bayi dan balita saat ini mengalami perkembangan yang pesat salah satunya dengan menggunakan terapi SPA. Terapi SPA (Solus Per Aqua) merupakan terapi dengan menggunakan terapi air, biasanya dalam penerapannya terapi SPA dipadukan dengan terapi sentuh (touch therapy) menggunakan pijatan (massage). Konsep terapi SPA yang diterapkan dalam asuhan pada bayi dan balita didasarkan pada kondisi bayi selama di dalam kandungan ibu yang berada dalam air ketuban yang hangat dan gelap selama 9 bulan setelah lahir harus berhadapan dengan suhu yang dingin. Melalui SPA bayi dan balita dapat merasakan relaksasi untuk menghilangkan stress pada bayi dan balita serta meningkatkan proses tumbuh kembang bayi dan balita.

Berdasarkan data dari WHO sebanyak 80% praktisi kesehatan di negara berkembang lebih memilih pengobatan alternatif dibandingkan pengobatan kimia (WHO, 2012). National Center for Health Statistic Survey (NCCAM) menganalisa lima

tahun terakhir ini terjadi peningkatan penggunaan terapi dan asuhan komplementer dari 36 % ke 62 %. Asuhan komplementer dipengaruhi oleh kebudayaan dan tradisi yang berkembang dimasyarakat. Tujuan dari asuhan komplementer adalah memberikan harmoni dan keseimbangan pada pemberian asuhan komplementer. Asuhan komplementer menjadi pelengkap dalam asuhan medis (Mc Elroy and Townsend, 2004)

Beberapa perawatan yang berpotensi membahayakan bayi baru lahir diantaranya pemotongan tali pusat yang tidak higienis dengan menggunakan peralatan tradisional, pemberian Air Susu Ibu tidak diberikan segera setelah bayi lahir, membuang Air Susu Ibu pada awal kelahiran bayi. Selain itu, memandikan bayi segera setelah lahir dan tidak menyelimuti bayi baru lahir. Beberapa orang menyetujui hal tersebut karena faktor kepercayaan dan alternatif asuhan. (Keterton, AJ et al, 2009).

. Di Indonesia, pijat bayi, penggunaan tanaman herbal yang dijadikan ramuan tradisional, ramuan tersebut biasanya ditempelkan kepala (pupuk) atau digunakan diseluruh tubuh (pilis) merupakan beberapa asuhan kebidanan komplementer yang sering di-gunakan pada perawatan bayi baru lahir.

Pupuk merupakan ramuan tradisional yang terbuat dari kemukus, beras kencur yang ditumbuk dan dicampur minyak telon digunakan dengan cara ditempelkan di kepala bayi. Pilis adalah ramuan tradisional yang dibuat dari tanaman obat kunyit dan daun sirih yang ditumbuk kemudian dibalurkan keseluruh tubuh bayi.

C. Jenis Asuhan Kebidanan Komplementer Pada Bayi Baru Lahir

Budaya dan tradisi merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam pelayanan kesehatan pada ibu dan anak. Bagaimanapun juga, tradisi dan budaya mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan bayi dan status kesehatannya. Adapun beberapa jenis asuhan kebidanan pada bayi baru lahir yang bisa menjadi pilihan bagi orang tua atau tenaga kesehatan yang lain:

1. Pijat Bayi (*Baby Massage*)

Pijat bayi (*baby massage*) di Indonesia telah secara turun menurun telah dipraktikan. Pijat bayi tradisional yang selama ini dipraktikkan hanya ditujukan untuk penyembuhan penyakit dan terkadang disertai dengan jamu. Karen ditujukan untuk menyembuhkan penyakit maka pijat ini sering dilakukan dengan paksaan, akibatnya bayi menangis keras dan meronta-ronta. Sehingga setelah dipijat bayi lelap karena kelelahan menangis, bukan karena rileks akibat pemijatan (*massage*).

Dalam pijat tradisional sering menggunakan bahan yang tidak terjamin aman untuk kulit bayi, misalnya dengan menggunakan parutan jahe dan bawang,

atau daun daunan yang dihancurkan. Ramuan ini mengandung minyak atsiri yang dapat menyebabkan gatal, panas atau perih pada kulit bayi. Dalam perkembangannya, terapi pijat pada bayi menjadi terapi pijat modern, dimana dalam terapi pijat modern tanpa menggunakan jamu atau obat apapun. Hanya menggunakan baby oil yang terbuat dari buah atau tumbuhan seperti minyak bayi, minyak zaitun murni, minyak kelapa vco, dan minyak biji anggur. Pijat bayi modern ini dapat dilakukan oleh orang tua, pengasuh, dan terapis yang dilatih oleh instructor professional bersertifikat. Pijat bayi ini memadukan antara ilmiah, kesehatan, seni, kasih dan sayang. Berbeda dengan pijat bayi tradisionial, pijat modern menunggu kesiapan bayi. Sehingga bayi dipijat dalam kondisi yang tenang dan menyenangkan tanpa adanya paksaan bahkan tangisan bayi. Hal ini akan membuat bayi senang sehingga bayi menjadi santai dan tidur pulas karena puas dan nyaman.

Beberapa hasil penelitian yang menjelaskan tentang manfaat baby massage adalah sebagai berikut:

- a. **Manfaat baby massage dalam memperbaiki pola tidur.** Bayi yang dipijat kurang dari 15 menit akan merasa lebih rileks dan lebih nyaman dan akan tertidur lelap dan lebih lama, apabila bayi mendapatkan waktu tidur yang cukup dengan lelap maka pertumbuhan dan perkembangan bayi akan semakin baik.
- b. **Manfaat lain dari pijat bayi adalah untuk membantu merangsang dan menyeimbangkan hormone-hormon kortisol dan oksitosin,** saat ibu memberikan pijatan pada tubuh bayi akan menyebabkan hormon kortisol (hormone stress) yang ada di dalam tubuh bayi berkurang. Dengan adanya penurunan hormone stress dalam badan bayi akan menyebabkan bayi lebih riang dan tidak suka menangis. Terapi pijatan akan mengakibatkan produksi hormone oksitosin meningkat. Hormone ini akan merangsang rasa nyaman dan kasih sayang sehingga terjalin ikatan psikologis yang kuat antara ibu dan bayinya. Oleh karena itu, setiap sentuhan yang bayi rasakan akan ditangkap sebagai bentuk kasih sayang dari ibunya.
- c. **Manfaat pijat bayi terhadap perbaikan imunitas bayi dan balita, dan menstimulasi enzim-enzim yang ada di dalam perut bayi.** Pijat bayi dapat meningkatkan imunitas bayi dan anak, dimana terapi pijat dapat meningkatkan produksi leukosit (sel darah putih) yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi sehingga bayi menjadi lebih sehat. Pijat akan menstimulasi enzim-enzim yang ada di perutnya sehingga penyerapan nutrisi dalam tubuh bayi akan lebih optimal.
- d. **Manfaat pijat bayi terhadap rangsangan saraf dan kulit.** Memijat bayi secara teratur dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan rangsangan saraf dan kulit bayi.

- e. **Manfaat pijat bayi terhadap peningkatan nafsu makan bayi.** Memijat bayi secara teratur dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan nafsu makan bayi. Pijatan pada perut bayi akan meningkatkan produksi hormone gastrin dan insulin yang berperan penting dalam proses penyerapan makanan. Pada bayi yang secara rutin dipijat akan meningkatkan produksi kedua hormone ini sehingga menyebabkan nafsu makan dan penyerapan makanan meningkat. Nafsu makan meningkat akan mengakibatkan berat badan bayi dan anak meningkat pula.
- f. **Manfaat pijat bayi terhadap kelancaran peredaran darah dan menguatkan otot-otot bayi.** Pijat bayi akan meningkatkan kelancaran peredaran darah dan menguatkan otot-otot bayi, sebuah penelitian membuktikan bahwa bayi premature yang diberi pijatan mengalami kenaikan berat badan 2x lipat dari pada bayi yang tidak diberi pijatan, selain itu mereka lebih aktif dan tanggap sehingga mampu bebas dari perawatan rumah sakit yang lebih cepat pula.
- g. **Manfaat pijat bayi untuk mengurangi keluhan kembung dan kolik.** Bayi yang aktif akan memiliki gerakan yang banyak dan terjadi ketegangan otot-otot sehingga membuat lebih mudah kembung, pijatan yang teratur dan lembut akan melemahkan otot-otot yang tegang.
- h. **Manfaat pijat bayi terhadap perkembangan motoric kasar bayi.** Terapi pijatan yang teratur akan memberikan stimulasi motoric kasar. Motorik kasar bayi akan berkembang dengan baik membutuhkan keseimbangan dan koordinasi antara anggota tubuh dengan otot-otot besar seperti otot lengan dan otot tungkai. Dengan melalui terapi pijatan dan terapi air (SPA) memungkinkan bayi untuk dapat mengeksplorasi tubuhnya sehingga otot-otot bayi akan mendapatkan stimulus perkembangan secara optimal.
- i. **Manfaat pijat bayi terhadap perkembangan motoric halus bayi.** Pijat bayi berhubungan dengan keterampilan fisik bayi yang melibatkan otot kecil dan koordinasi dengan mata dan tangan, stimulasi dilakukan dengan cara mengajak bayi bermain, berbicara dan melakukan kegiatan yang dapat memberikan stimulasi pada gerakan tangan bayi.
- j. **Manfaat pijat bayi terhadap perkembangan otak bayi secara optimal.** Pijat bayi bermanfaat terhadap perkembangan otak bayi secara optimal, melalui gerakan pemijatan. Pada saat bayi dipijat terjadi stimulasi dari adanya gerakan sentuhan pada pijatan, sentuhan ini akan merangsang tumbuh kembang fisik dan otak bayi dan dapat menstimulasi sinapsis yang akan sering diaktifkan sehingga menjasi semakin kuat, pertumbuhan otak bayi pun akan semakin optimal.
- k. **Manfaat pijat bayi terhadap kemampuan bahasa/ linguistic bayi sesuai dengan tahap perkembangan usianya.** Pijat bayi memberikan stimulasi

pada kemampuan bahasa /linguistic bayi. Pada saat dilakukan pemijatan akan terjadi komunikasi baik verbal maupun non verbal antara ibu / terapis dengan bayi. Pada saat ibu / terapis memijat dianjurkan untuk mengajak bayi berbicara menjelaskan kegiatan yang dilakukan diiringi dengan ekspresi muka seperti tersenyum dan tertawa. Kegiatan ini akan memberikan stimulasi perkembangan sel sensorik pada kemampuan bahasa / linguistic bayi baik secara verbal dan non verbal. Bayi akan lebih dini mengenal tentang ungkapan emosi dalam bahasa kasih sayang melalui ekspresi.

- I. Manfaat pijat bayi terhadap kesehatan organ tubuh dan optimalisasi kemampuan organ sensoris.** Pijat bayi bermanfaat terhadap kesehatan organ tubuh dan optimalisasi kemampuan organ sensoris, dalam pijat bayi terdapat stimulasi pada titik-titik acupressure yang berhubungan dengan fungsi indera peraba, penciuman, penglihatan pendengaran serta terhadap keseimbangan. Treatment SPA juga sangat bermanfaat terhadap kesehatan bayi, terapi SPA akan mengkondisikan bayi terhadap keseimbangan dan koordinasi gerak bayi karena adanya gravitasi air yang tidak terlalu besar sehingga dapat melatih otot-otot lebih efektif.

Pada saat ibu atau terapis melakukan Treatment baby massage harus memperhatikan kondisi bayi, berikut ini merupakan kondisi yang dapat dialami oleh bayi pada saat akan dilakukan pijat bayi :

1. Bayi siap dipijat
 - a. Kontak mata
 - b. Awake
 - c. Alert
 - d. Mengoceh
 - e. Tangan terbuka
 - f. Tersenyum
 - g. Kaki menggosok
 - h. Santai
 - i. Semangat
 - j. Meraih /menggapai
2. Bayi tidak siap dipijat /menolak
 - a. Tidak ada kontak mata
 - b. Mengantuk
 - c. Menangis
 - d. Tangan digenggam
 - e. Kepala memutar balik
 - f. Ketegangan
 - g. Kulit berbintik-bintik
 - h. kekakuan

Terapi baby massage menggunakan minyak untuk mengurut / oil massage. Berdasarkan rekomendasi dari IMIS minyak yang digunakan untuk pijat bayi adalah minyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan / bahan organik yang tidak berbau, tidak berasa, simple, proses pengolahan dengan menggunakan teknik 'cold press oil' misalnya dengan menggunakan minyak dari biji anggur, bunga matahari, minyak kelapa atau dengan minyak dari buah almond. Secara biokimiawi minyak tersebut sesuai dengan kondisi bayi sehingga mudah dicerna dan mudah berasimilasi dengan kulit, sehingga tidak berbahaya apabila tertelan oleh bayi. Yang paling dianjurkan adalah minyak / oil dari bahan biji anggur atau grapeseed oil karena memiliki PH yang sesuai dengan PH kulit bayi sehingga tidak mengiritasi.

Minyak / oil yang harus dihindari adalah minyak yang terbuat dari bahan-bahan berikut ini:

- a) Minyak yang mengandung bahan kimia, berbau dan berparfum
- b) Minyak sintesis atau minyak mineral berbasis dasar petrol (bensin)
- c) Esensial oil (minyak atsiri) yang berasal dari tanaman tertentu (tanaman obat)

Minyak dengan bahan-bahan di atas tidak cocok untuk kulit bayi karena konsentrasinya yang terlalu pekat dan baunya terlalu menyengat serta terlalu menstimulasi otak dan sel-sel tubuh.

Sebelum melakukan terapi pijat bayi seorang ibu atau terapis harus mempersiapkan beberapa peralatan dan lingkungan, antara lain:

1. Waktu yang tepat Waktu yang paling tepat dilakukan pijat bayi adalah pada saat bayi menunjukkan respon "siap" untuk dipijat. Pijat bayi dapat dilakukan segera setelah bayi dilahirkan sesuai dengan keinginan orang tua. Pemijatan dapat dilakukan pada waktu-waktu berikut ini :
 - Pagi hari, pada saat orang tua dan anak siap untuk memulai hari baru
 - Malam hari, sebelum tidur, waktu ini sangat baik untuk membantu bayi tidur lebih nyenyak.
2. Ruangan Dibutuhkan ruangan yang nyaman, hangat, tidak ada lampu di atas bagian kepala bayi, tidak bising dan design ruangan treatment yang menarik.
3. Persiapan alat
 - a. Alas yang empuk dan lembut
 - b. Handuk atau lap, popok dan baju ganti
 - c. Minyak untuk memijat
 - d. Air hangat, waslap dan tissue
4. Persiapan pemijat
 - a. Pemijat mencuci tangan sebelum memijat bayi dan pastikan kuku pemijat harus pendek

- b. Cincin, jam tangan, atau barang yang berpotensi melukai bayi harus dilepas
 - c. Alat komunikasi sebaiknya diposisikan dalam mode 'silent' atau dimatikan
 - d. Usahakan terapis dalam kondisi fit
5. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pijat bayi
- a. Sebelum memijat, terapis harus melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, hal ini dilakukan untuk memastikan bayi tidak ada memar ataupun luka.
 - b. Memandang mata bayi, disertai dengan pancaran kasih sayang.
 - c. Pada saat melakukan treatment usahakan terapis mengiringi dengan menyanyikan lagu atau memutar lagu-lagu yang tenang / lembut.
 - d. Awali pemijatan dengan sentuhan ringan, kemudian secara bertahap menambahkan tekanan pada sentuhan yang dilakukan, khususnya apabila terapis sudah merasa yakin bahwa bayi mulai terbiasa dengan pemijatan yang sedang dilakukan.
 - e. Sebelum dilakukan pemijatan, lumurkan minyak yang lembut sesering mungkin.
 - f. Sebaiknya pemijatan dimulai dari kaki bayi karena pada umumnya bayi lebih menerima apabila dipijat pada daerah kaki.
 - g. Tanggap pada isyarat yang diberikan oleh bayi, bila bayi menangis cobalah untuk menenangkan bayi sebelum melakukan atau melanjutkan pemijatan. Bila bayi menangis lebih kuat hentikan pemijatan sementara karena mungkin bayi berharap untuk digendong, disusui atau sudah sangat ingin tidur.
 - h. Hindarkan mata bayi dari oil massage.
 - i. Libatkan orang tua dalam proses pemijatan agar bayi lebih tenang dan terjalin hubungan yang baik antara orang tua dan bayi serta terapis.
 - j. Pijat bayi sebaiknya dilakukan oleh orang tua bayi sendiri, untuk memperlambat bonding.
 - k. Hindari memijat bayi setelah selesai menyusu atau setelah makan.
 - l. Hindari membangunkan bayi khusus untuk pemijatan.
 - m. Hindari memijat bayi pada saat bayi dalam keadaan tidak sehat.
 - n. Hindari memijat bayi pada saat bayi tidak mau dipijat.
 - o. Hindari memaksakan posisi pijat tertentu pada bayi

Teknik pijat bayi merupakan ilmu yang sangat mudah dipelajari oleh siapa saja termasuk orang tua dan orang-orang terdekat bayi (misal: nenek, kakek, atau baby sitter). Setelah teknik-teknik dasar selesai dipelajari, pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bayi maupun masing-

masing pemijatnya. Tidak ada teknik atau cara pijat yang baku, setiap individu dapat melakukan sesuai teknik, cara dan keinginannya yang khusus dan tersendiri. Susunan / urutan bagian tubuh yang akan dipijat juga disesuaikan secara individual sesuai dengan kesukaan bayi, dianjurkan dimulai dari kaki.

Orang tua bayi dapat melakukan pemijatan kepada anaknya, khususnya ayah dapat mempraktikkan pijat bayi kepada anaknya. Dewasa ini banyak para ayah yang ingin berperan dalam merawat bayinya meskipun pada umumnya mereka hanya memiliki waktu yang sangat terbatas karena kesibukannya mencari nafkah. Selain itu beberapa ayah merasa canggung untuk ikut merawat bayinya karena adanya stigma di masyarakat bahwa tugas mengurus anak-anak dan rumah tangga adalah tugas istri saja. Dengan ayah berperan dalam melaksanakan praktik pijat bayi kepada bayinya, akan mendorong seorang ayah untuk memulai peran dalam merawat bayinya. Pijat adalah bentuk upaya pemeliharaan kesehatan yang sangat disenangi oleh para ayah. Dengan melakukan pemijatan akan terbuka kesempatan bagi seorang ayah untuk menjalin kontak batin dengan bayinya. Para ayah yang melakukan pemijatan pada bayinya akan mengingat hal ini sebagai pengalaman yang sangat menyenangkan dan membanggakannya. Penelitian di Australia membuktikan bahwa bayi yang dipijat oleh ayahnya mempunyai kecenderungan berat badannya naik dan hubungan (*bonding*) dengan ayah akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan bayi yang tidak dipijat oleh ayahnya.

Pemijatan tidak hanya dianjurkan dilakukan oleh ayah saja namun juga dianjurkan dilakukan oleh nenek dan kakek si bayi. Pada salah satu penelitian yang meneliti sekelompok nenek dan kakek yang dengan sukarela memijat bayi-bayi yang terlantar yang berusia antara 3-18 bulan. Penelitian tersebut membuktikan bahwa para kakek dan nenek tadi mendapat keuntungan yang lebih banyak dari kegiatan memijat bayi tersebut. Dari pendataan pada kakek dan nenek yang ikut berpartisipasi dalam penelitian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Ketegangan kakek dan nenek berkurang.
- b. Terjadi peningkatan rasa percaya diri, disamping terjadinya perubahan cara hidup mereka antara lain ditandai dengan berkurangnya frekuensi kunjungan ke dokter dan mereka dapat melakukan hubungan sosial yang lebih banyak.
- c. Denyut nadi mereka menjadi lebih rendah dan mereka juga menjadi lebih rileks.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemijatan bayi yang dilakukan oleh nenek dan kakek tidak hanya bermanfaat bagi bayi saja namun juga untuk nenek dan kakek yang mempraktikkan banyak mendapatkan manfaat dari praktik tersebut. Nenek dan kakek dapat mempraktikkan pemijatan kepada

cucunya, bahkan seringkali lebih terampil dan sensitive dalam melakukannya. Hal ini kemungkinan karena ada kaitannya dengan pengalamannya terdahulu dalam menangani anak-anaknya.

2. Baby Gym

Baby gym adalah gerakan senam bayi sehat yang bertujuan untuk relaksasi dan stimulasi bagi bayi. Baby gym biasanya digunakan juga sebagai pemanasan sebelum bayi melakukan terapi SPA. Tujuan dilakukan baby gym adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat otot-otot dan persendian
- b. Meningkatkan koordinasi dan keseimbangan
- c. Meningkatkan fleksibilitas dan atau kelenturan tubuh
- d. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan fungsi anggota gerak tubuh
- e. Memperlancar peredaran darah dan menguatkan jantung
- f. Meningkatkan ketahanan tubuh
- g. Meningkatkan kewaspadaan
- h. Memperkuat interaksi antara orang tua dan bayi

3. Brain Gym / Senam Otak

Brain Gym / senam otak adalah serangkaian gerak sederhana yang menyenangkan. Gerakangerakan brain gym atau senam otak adalah suatu sentuhan yang bisa merangsang kerja dan berfungsinya otak secara optimal. Yaitu lebih mengaktifkan kemampuan otak kanan dan kiri, sehingga kerjasama antara belahan otak kanan dan kiri bisa terjalin.

4. Terapi SPA dan Swimming pada Bayi

a) Definisi SPA

SPA berasal dari bahasa latin yang memiliki arti ‘Solus’ (pengobatan / perawatan), Per (dengan) Aqua (air). Menurut Permenkes No.8 tahun 2014, pelayanan kesehatan SPA adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan secara holistic dengan memadukan berbagai jenis perawatan kesehatan tradisional dan modern yang menggunakan air beserta pendukung perawatan lainnya berupa pijat, penggunaan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi wara, terapi musik, dan makanan untuk memberikan efek terapi melalui panca indera guna mencapai keseimbangan antara tubuh (body), pikiran (mind) dan jiwa (soul) sehingga terwujud kondisi kesehatan yang optimal.

b) Manfaat SPA untuk bayi.

Manfaat SPA untuk bayi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pertumbuhan fisik dan perkembangan mental
- b. Meningkatkan perkembangan sensorik

- c. Meningkatkan kepercayaan diri
- d. Meningkatkan kapasitas paru-paru memperkuat jantung
- e. Meningkatkan berat badan
- f. Stimulasi mental, sirkulasi darah untuk pertumbuhan otak dan meningkatkan IQ
- g. Membangun system saraf, mengurangi stress, membantu agar anak tidur dengan teratur
- h. Meregangkan otot, meluruskan struktur tubuh dan persendian setelah lahir
- i. Aerobic, memperkuat jantung, menambah nafsu makan
- j. Terapi untuk bayi premature dan bayi dengan icterus (kuning)
- k. Kenyamanan lingkungan bagi bayi yang tinggal 7-9 bulan di dalam air dan di atas tanah

c) Definisi Swimming Baby

Berenang adalah salah satu jenis olahraga yang mampu meningkatkan kesehatan seseorang yang juga merupakan olahraga tanpa gaya gravitasi bumi (non weight bearing). Berenang terbilang minim risiko dan cedera fisik karena saat berenang seluruh berat badan ditahan di air atau mengapung. Berenang tidak sekedar untuk kesehatan tetapi juga untuk rekreasi yang sangat menyenangkan. Berenang adalah salah satu life skill atau keahlian yang diperlukan dalam hidup yang sangat diperlukan di masa depan.

d) Manfaat Berenang pada Bayi

Berenang memiliki banyak manfaat diantaranya sebagai berikut :

- a. Berenang sangat baik untuk kesehatan bayi dan mencegah bayi mengalami ketakutan terhadap air.
- b. Air membantu meningkatkan koordinasi dan keseimbangan, kurangnya gravitasi juga berarti bahwa bayi melatih otot-otot lebih efektif dalam air daripada di darat.
- c. Sebuah penelitian di Jerman menemukan bahwa bayi yang berenang dapat meningkatkan perkembangan motoric, keterampilan sosial dan kecerdasan.
- d. Membantu perkembangan otak dan sebagai rekreasi bagi bayi Belajar untuk merespon perintah dapat membuat bayi lebih tajam secara mental dan meningkatkan tingkat pemahaman.
- e. Berenang secara teratur dalam air hangat baik untuk relaksasi, merangsang nafsu makan, menyebabkan tidur dan pola makan meningkat.
- f. Mencegah fobia air di kemudian hari

5. Pediatric Massage Therapy

Massage / pijatan dapat dimanfaatkan juga dalam pengobatan atau terapi. Massage therapy merupakan suatu bentuk terapi yang menggunakan sentuhan kelembutan yang sistematis, yang difokuskan pada bagian tubuh tertentu atau secara keseluruhan dengan tujuan untuk penyembuhan dan relaksasi.

Massage therapy bagi anak-anak sangat berperan sebagai booster terhadap stress, karena sering kali anak-anak mendapatkan stress yang kuat dari lingkungan sekitarnya (di sekolah, lingkungan rumah, teman bermain, dll). Stress dapat menyebabkan ketidak seimbangan system imun dan system hormone. Dengan memberikan massage secara rutin akan dapat membantu menurunkan stress sehingga anak-anak bisa tidur nyenyak. Anak-anak akan merespon positif terhadap berbagai bentuk massage. Sensasi sentuhan dan bounding memberikan efek terapeutik pada anak yang sedang dimassage, sehingga kadang akan tertidur sebelum massage selesai. Hal ini merupakan tanda atau point effect positive dari therapy massage.

Pediatric massage therapy didefinisikan sebagai manipulasi secara manual pada jaringan lunak untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bagi anak-anak dengan tekanan, kecepatan dan teknik yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Dalam pediatric massage therapy kecepatan tekanan harus disesuaikan dengan tujuannya dimana ada bagian tubuh tertentu yang tidak boleh dipijat atau harus diberikan kecepatan yang tinggi berulang-ulang.

Pediatric massage therapy sangat efektif untuk anak-anak yang menderita asma, batuk, pilek, konstipasi dan kolik abdomen atau juga arthritis pada bayi serta bayi premature. Selain pada anak-anak dengan kondisi tersebut Pediatric massage therapy berguna juga pada anak-anak dengan kebutuhan khusus diantaranya hyperaktivitas, depressive, autisme dan cerebral palsy. Massage therapy juga sangat direkomendasikan bagi anak yang menderita kanker karena dapat meningkatkan imunitas dan menurunkan stress.

DAFTAR PUSTAKA

- Armini, N. W. 2016. Hypnobreastfeeding Awali Suksesnya ASI Eksklusif. Jurnal Skala Husada Vol.13 No.1 April 2016.
- Ayuningtyas, Ika Fitria. 2019. Asuhan Komplementer Terapi Komplementer dalam Kebidanan. Yogyakarta : Pustaka Baru.
- Benjamin DR, Van De Water AT, Pelvis CL. Effect of Exercise on Diastasis of The Rectus Abdominis Muscle in The Antenatal and Postnatal Periods : Systematic Review. Physiotherapy. 2014. Mar : 100 (1) 1-8 DOI : 10.1016/J.Physio.2013.08.005.Epub 2013 Oct 5.
- Ernst E, Resch KL, Mills S, Hill R, Mitchell A, Willoughby M, White A: Complementary medicine – a definition. Br J Gen Pract 2002, 45:506.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1025/MENKES/PER/X/2004 tentang pedoman persyaratan kesehatan pelayanan kesehatan menggunakan air, peraturan ini mengatur tentang terapi SPA (solus per aqua) / aqua therapy atau yang biasa disebut dengan terapi sehat menggunakan terapi air.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 120/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Hiperbarik.
- Kesterton, AJ., Cleland, J. 2009. Neonatal Care In Rural Karnataka: Healthy And Harmful Practices, The Potential For Change. BMC Pregnancy and Childbirth 2009, 9 :20 doi:10.1186/1471-2393-9- 20. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2693491/pdf/1471-2393-9-20.pdf>
- Lindquits, R., Synder, M., Tracy, MF. 2014. Complementary and Alternative Therapy in Nursing. Springer Publishing Company. http://lghttp.48653.nexcesscdn.net/80223CF/springerstatic/media/samplechapters/9780826196125/9780826196125_chapter.pdf
- McElroy, A., & Townsend, P. (2004). Medical anthropology in ecological perspective. Boulder, CO: Westview Press.
- National Center for Complementary and Alternative Medicine. (2008a). The uses of complementary and alternative medicine in the United States. Retrieved from http://nccam.nih.gov/news/camsurvey_fs1.htm
- Nguyen, L. T., Davis, R. B., Kaptchuk, T. J., & Phillips, R. S. (2011). Use of complementary and alternative medicine and self-rated health status: Results from a national survey. Journal of General Internal Medicine, 26(4), 399–404.
- Nurul, M. Kusmini. Sutarmi. 2017. Healthy Mom Baby Massage and SPA. Semarang : IHCA
- Roesli, Utami. 2007. Pedoman Pijat Bayi (Edisi Revisi). Jakarta : Trubus Agriwidaya

- Singer, M., & Baer, H. (2012). *Introducing medical anthropology: A discipline in action*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Struthers, R., & Nichols, L. A. (2004). Utilization of complementary and alternative medicine among racial and ethnic minority populations. Implications for reducing health care disparities. In J. Fitzpatrick & A. Villarruel (Eds.), *Annual review of nursing research* (Vol. 22, pp. 285–313).
- Synder, M., Niska, K., Lindquits, R. 2014. *Evolution and Use of Complementary and Alternative Therapies*.
- World Health Organization. (2012). Health of indigenous peoples. Retrieved from <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs326/en/index.html>
- <http://e-repository.stikesmedistra-indonesia.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/434/naskah%20buku%20komplementer.edit%20kirim.pdf?sequence=6>
- https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=CDFqEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=asuhan+kebidanan+komplementer&ots=8-Y0Nm7Bg6&sig=z_6eyLow4sgLkA4iYeDAawoLh_Q&redir_esc=y#v=onepage&q=asuhan%20kebidanan%20komplementer&f=false
- https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=kebidanan+komplementer+perawatan+bayi+baru&oq=konsep+asuhan+kebidanan+komplementer+bbl

SINOPSIS

Buku ini secara umum memuat tentang Asuhan Kebidanan pada Bayi Baru lahir. Dengan mempelajari Asuhan Kebidanan pada Bayi Baru lahir diharapkan Mahasiswa Kebidanan mampu memberikan Asuhan secara komprehensif. Selain itu, buku ini dijadikan referensi bagi mahasiswa kebidanan yang kelak menjadi tenaga Kesehatan yang profesional, berkualitas dan berdaya saing tinggi demi mewujudkan bangsa Indonesia yang Sehat.

Pembahasan dalam Buku Ini mencakup:

Bab 1 Asuhan Kebidanan Segera dan Lanjutan pada Bayi Baru Lahir

Bab 2 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Bab 3 Asuhan Kebidanan pada Bayi Baru Lahir dengan Masalah

Bab 4 Imunisasi

Bab 5 Infeksi pada Neonatus dan Pencegahannya

Bab 6 Asuhan Kebidanan Komplementer pada Bayi Baru Lahir

Dengan Bahasa yang sederhana dan pembahasan yang runtut di setiap bab-nya, menjadikan materi yang disampaikan mudah diikuti dan dipahami.

Buku ini secara umum memuat tentang Asuhan Kebidanan pada Bayi Baru lahir. Dengan mempelajari Asuhan Kebidanan pada Bayi Baru lahir diharapkan Mahasiswa Kebidanan mampu memberikan Asuhan secara komprehensif. Selain itu, buku ini dijadikan referensi bagi mahasiswa kebidanan yang kelak menjadi tenaga Kesehatan yang professional, berkualitas dan berdaya saing tinggi demi mewujudkan bangsa Indonesia yang Sehat.

Pembahasan dalam Buku Ini mencakup:

Bab 1 Asuhan Kebidanan Segera dan Lanjutan pada Bayi Baru Lahir

Bab 2 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Bab 3 Asuhan Kebidanan pada Bayi Baru Lahir dengan Masalah

Bab 4 Imunisasi

Bab 5 Infeksi pada Neonatus dan Pencegahannya

Bab 6 Asuhan Kebidanan Komplementer pada Bayi Baru Lahir

Dengan Bahasa yang sederhana dan pembahasan yang runtut di setiap bab-nya, menjadikan materi yang disampaikan mudah diikuti dan dipahami.

ISBN 978-623-88659-1-8



Anggota IKAPI
No. 624/DKI/2022

Penerbit :
PT Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F
Jalan S. Parman Kav. 22-24
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480
Telp: (021) 29866919